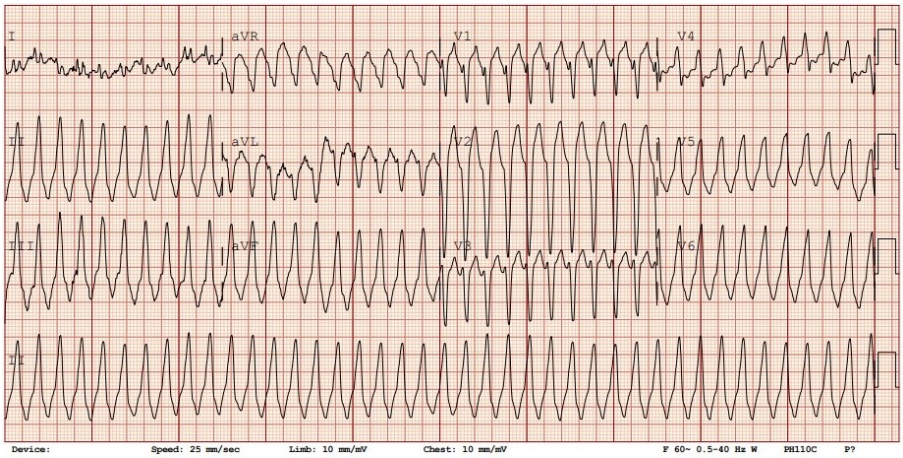
# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 1. | 42 歲男性進食海鮮後，4 小時內出現急性腹瀉及輕度噁心至急診。病人否認發燒或嚴重脫水。根據病史，懷疑可能與進食未充分烹煮的海魚有關。基於目前病史及潛在的潛伏期，最可能的病原體為何？<br>（A）克雷伯氏菌（*Klebsiella*）。<br>（B）沙門氏菌（*Salmonella*）。<br>（C）諾羅病毒（Norovirus）。<br>（D）糞腸球菌（*Enterococcus*）。 |
| B | 2. | 56 歲女性有肺動脈高壓長期追蹤，因呼吸急促至急診，神智清楚但口唇發紺，$SpO_2$ 89%、血壓 85/55 mmHg、心跳 105 次/min、呼吸 26 次/min。超音波顯示右心室擴大、右心功能下降、心室中隔左偏。經評估無明顯液體過負荷。下列藥物組合較適合初始使用於此類病人，以改善右心輸出與維持冠狀動脈灌流？<br>（A）Dopamine + Phenylephrine。<br>（B）Dobutamine + Norepinephrine。<br>（C）Phenylephrine + Epinephrine。<br>（D）Milrinone + Norepinephrine。 |
| A | 3. | 45 歲男性，無過去病史，因肛門劇烈疼痛及排便時有鮮血來急診。病人近期無發燒、無體重減輕，排便習慣正常。肛門檢查發現 1 cm 長的線狀潰瘍，潰瘍底部乾淨，無明顯膿液，下列處置何者較適當？<br>（A）建議熱敷及坐浴，增加膳食纖維攝取，並使用局部麻醉藥膏。<br>（B）立即行大腸鏡檢查，並考慮冷凍切片以排除惡性病變。<br>（C）施行肛門擴張術以促進傷口癒合。<br>（D）立即進行手術切除潰瘍並縫合傷口。 |
| C | 4. | 妊娠 38 週孕婦，主訴陣痛頻繁。檢查發現胎頭已達陰道口，心跳 120 次/min，血壓 90/60 mmHg。胎心音規律 100 次/min。下列處置何者較適當？<br>（A）立即給予靜脈輸液並施行剖腹產。<br>（B）讓孕婦躺平並轉送到產房給產科醫師處理。<br>（C）就地準備接生並注意胎兒窘迫的可能性。<br>（D）使用 tocolytics（如 Terbutaline）延遲生產。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 5. | 工人誤觸化學物質後出現皮膚灼熱、眼睛刺激與乾咳。到院時意識清楚、生命徵象穩定，無明顯皮膚損傷。病人穿著工作制服與鞋靴，站在急診入口等候。下列初步處置何者較適當？<br>（A）立即使用大量生理食鹽水沖洗眼睛和皮膚。<br>（B）先安排病人進入急診室進一步評估和檢查。<br>（C）要求病人立即脫去污染衣物並刷除粉塵，乾洗臉部。<br>（D）先詢問物質名稱以判斷是否需去污，並靜待毒物小組建議後再行動。 |
| A | 6. | 50 歲男性於走路時短暫失去意識約 1 分鐘，被送至急診。生命徵象正常，無身體不適，但失去意識前曾感到胸悶，心電圖無明顯 ST 段變化。下列診斷何者可能性最低？<br>（A）左冠狀動脈源自肺動脈（ALCAPA syndrome）。<br>（B）主動脈瓣狹窄（aortic stenosis）。<br>（C）肥厚性心肌病變（hypertrophic cardiomyopathy）。<br>（D）勒內格爾症（Lenègre's disease）。 |
| B | 7. | 51 歲女性突發心悸持續約 8 小時、輕微呼吸喘及頭暈冒汗就醫。無慢性高血壓病史，但最近幾個月"易冒汗發熱手抖"，頸部有腫塊。心電圖顯示如下圖，生命徵象：GCS E4V5M6，血壓 126/70 mmHg，血氧飽和度 96%。下列藥物治療何者較適當？<br>  <br><br>（A）Amiodarone。<br>（B）Esmolol。<br>（C）$MgSO_4$。<br>（D）Lidocaine。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| A | 8. | 25 歲男性，氣喘病史，主訴呼吸急促，生命徵象體溫 38.1℃、心跳 121 次/min、呼吸 30 次/min，血壓 141/100 mmHg，$SpO_2$ 85%，講話斷斷續續、臉色蒼白及冒冷汗，胸部 X 光無明顯異常，下列何者較不適當？<br>（A）插管後呼吸器應設定增加進氣流速與換氣頻率（20~24 次/min）。<br>（B）聽診呼吸音無喘鳴聲（wheezing），仍可能是氣喘急性發作。<br>（C）在到達急診 1 小時內給予口服或靜脈注射類固醇可以降低住院率。<br>（D）Ipratropium bromide 應該與短效 β-agonist 合併使用，不能單獨當作第一線治療。 |
| A | 9. | 關於破傷風免疫球蛋白（Tetanus immunoglobulin）的敘述，下列何者較不適當？<br>（A）可以中和血液中與已經進入神經系統的破傷風毒素（tetanospasmin），改善臨床症狀、降低死亡率。<br>（B）疫苗注射狀況不明與明顯染污的傷口，預防劑量為單次肌肉注射成人 250 units、兒童 4 units/kg。<br>（C）感染破傷風後，建議治療劑量為單次肌肉注射 3,000~6,000 units。<br>（D）應於傷口清創前給予，並將部分劑量注射於傷口周圍，以減少清創時破傷風毒素的釋放與吸收。 |
| A | 10. | 下列關於 PECARN，CATCH，CALICE，NEXUS II 等小兒頭部外傷的臨床評估工具，下列敘述何者較適當？<br>（A）NEXUS II 相較於其他三種評估工具較適用於全年齡層的急診病人。<br>（B）昏迷指數 12 分，可以用 PECARN 來決定是否安排頭部電腦斷層。<br>（C）PECARN 識別高風險兒童，小於 3 歲與大於 3 歲提供不同標準。<br>（D）四種臨床評估工具敏感度都很高，特異度方面 CHALICE 是四種裡面最低的。 |
| C | 11. | 65 歲男性，高血壓、冠心症病史，規律服用 Aspirin。突然出現頭暈、虛弱及解大量血便。腹部身體診察無明顯異狀。目前血壓 80/50 mmHg，心跳 120 次/min，皮膚濕冷。抽血報告：Hb 8.5 g/dL，BUN 45 mg/dL，Creatinine 1.2 mg/dL。下列敘述何者較適當？<br>（A）依照抽血之 BUN/Cr 比值判斷，下消化道出血的可能性較高。<br>（B）若鼻胃管抽吸未見咖啡色液體或血液，可排除上消化道出血。<br>（C）應立即進行消化道內視鏡。<br>（D）應立即進行腹部電腦斷層。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| D | 12. | 5 歲男童約 24 小時前誤食不明殺鼠藥，無出血症狀，生命徵象穩定。INR 10.8，血色素及血小板皆正常，PT 明顯延長。下列敘述何者較適當？<br>（A）Superwarfarin 效果可長達數月，應給予維生素 K1 與新鮮冷凍血漿以預防出血。<br>（B）Superwarfarin 與 Warfarin 結構類似，中毒時可由常規 Warfarin assay 加以確認診斷。<br>（C）小兒即使少量誤食也極易出現嚴重出血，因此應常規給予維生素 K1 預防。<br>（D）即使 INR >10，但若無出血症狀，可先以口服維生素 K1 治療並密切追蹤 INR 變化。 |
| B | 13. | 66 歲 COPD 男性長期服用 Theophylline，上週服用家醫科處方 Erythromycin，近日出現噁心、失眠、顫抖與食慾不振，今日突然癲癇發作。血中 Theophylline 濃度為 41 μg/mL（治療濃度 8~20 μg/mL）。下列敘述何者較適當？<br>（A）長期使用 Theophylline 有高機率會導致代謝減低與藥物濃度累積。<br>（B）Erythromycin 抑制 CYP1A2，減慢 Theophylline 代謝，導致中毒。<br>（C）應考慮潛在腎功能異常導致累積，需抽血檢查肌肝酸。<br>（D）Theophylline 在這位病人身上，濃度在 50 μg/mL 屬於安全範圍。 |
| D | 14. | 67 歲男性，長期酗酒，有口腔癌病史，近半年來無住院病史，因發燒、咳嗽並伴隨濃痰 3 天來急診。身體診察發現右下肺，有濕囉音。胸部 X 光顯示右下葉浸潤。下列敘述何者較不適當？<br>（A）最常見的病原體是肺炎鏈球菌 （*Streptococcus pneumoniae*），需要同時考慮克雷伯氏菌屬（*Klebsiella species*）和嗜血桿菌屬（*Haemophilus species*）。<br>（B）進行退伍軍人肺炎尿液抗原快速檢測（Legionella urine antigen test）。<br>（C）此病人需要住院，抗生素的選擇為靜脈注射 Ceftriaxone + Azithromycin。<br>（D）CURB-65 評分系統相較於 pneumonia severity index 有更多實證研究證據。 |
| D | 15. | 關於下消化道出血的可能病因與臨床特徵，下列敘述何者較適當？<br>（A）直腸癌是最常見的急性大量出血原因。<br>（B）憩室出血通常會有腹部壓痛表現。<br>（C）血管擴張病變（vascular ectasia）常伴隨明顯腹痛。<br>（D）多數病人會自行緩解。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| B | 16. | 下面哪一個因素對 SIDS（Sudden Infant Death Syndrome）風險的影響與其他三者不同？<br>（A）母乳哺育（breast feeding）。<br>（B）使用包巾（swaddling）。<br>（C）使用奶嘴（pacifier）。<br>（D）接種疫苗（immunizations）。 |
| C | 17. | 80 歲男性頭部外傷到急診，有服用 Dabigatran 治療慢性心房顫動。無失去意識，主訴輕微頭暈，無噁心或視力模糊。下列處置何者較適當？<br>（A）給予頭部外傷衛教單可出院，若有症狀再回診。<br>（B）安排 Bleeding Time 檢查，若正常則可出院。<br>（C）立刻安排無顯影劑腦部 CT 評估有無顱內出血。<br>（D）預防性給予 Idarucizumab 以防遲發性顱內出血。 |
| A | 18. | 58 歲女性有風濕性心臟病和心房顫動（服用 Warfarin）病史，因過去 6 小時開始咳嗽合併血痰、急性呼吸困難來急診就診。生命徵象：體溫 36.8℃、心跳 145 次/min，血壓 85/40 mmHg，呼吸 32 次/min，身體診察顯示頸靜脈怒張，全肺瀰漫性囉音，以及心尖部 3/6 holosystolic murmur。實驗室結果 troponin I 0.12 ng /mL、BNP 3,450 pg /mL、INR 4.7。POCUS 左心房嚴重擴大，嚴重二尖瓣閉鎖不全伴隨後葉片呈現明顯飄動（flail）現象，和嚴重肺高壓。下列診斷及處置何者較適當？<br>（A）急性二尖瓣閉鎖不全合併乳頭肌破裂和心因性休克；給予升壓藥、緊急心臟外科會診並考慮手術。<br>（B）肺栓塞合併右心衰竭；給予 prothrombin 拮抗 Warfarin 後實施 t-PA 治療。<br>（C）急性冠心症導致乳頭肌破裂和二尖瓣閉鎖不全；給予升壓藥物並安排心導管和機械輔助。<br>（D）風濕性心臟病急性發作合併肺水腫；給予利尿劑和 IV Nitrates。 |
| D | 19. | 58 歲男性，有第二型糖尿病、高血壓、長期抽菸病史，因胸痛 1 小時至急診，無放射痛、無盜汗，活動時未加劇，生命徵象穩定，心電圖：輕微 T 波倒置（非特異性變化），無 ST 段抬高或壓低。首次 hs-troponin：10 ng/L（正常範圍 <14 ng/L）。HEAR Score=5，根據目前 HEART pathway 風險分層策略，下列處置何者較適當？<br>（A）病人 HEAR Score 屬於高風險應立即心導管檢查。<br>（B）病人 HEAR Score 屬於低風險可直接出院，無需進一步追蹤。<br>（C）立即給予雙重抗血小板治療，並安排住院觀察。<br>（D）觀察 3 小時並重測 hs-troponin 為陰性，需安排 stress testing 檢查。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| B | 20. | 58 歲男性，有肝硬化病史，因吐血就醫。病人意識清楚，血壓 85/50 mmHg，心跳 118 次/min，正在接受靜脈輸液與輸血治療。考慮執行鼻胃管抽吸。請問對此病人進行鼻胃管抽吸較適當之目的為何？<br>（A）確定出血來源。<br>（B）評估上消化道出血的嚴重程度與速度。<br>（C）判斷出血是否來自十二指腸。<br>（D）排除上消化道出血的可能性。 |
| C | 21. | 34 歲女性，懷孕 28 週，主訴右側下腹悶痛 2 天，伴隨頻尿與輕微噁心，無發燒。床邊超音波發現右側腎水腫。尿液檢查顯示：白血球 100~120 /HPF、紅血球 50~99 /HPF、Nitrite：negative，血液檢查：Creatinine 從 baseline 0.7 mg/dL 上升至 1.4 mg/dL。下列處置何者較適當？<br>（A）常規安排 MRI urography 評估是否有輸尿管阻塞。<br>（B）給予 Levofloxacin 靜脈注射作為初始抗生素治療。<br>（C）建議使用 Ceftriaxone 靜脈注射，並持續監測胎兒與腎功能變化。<br>（D）給予 Trimethoprim-sulfamethoxazole 口服 5 天療程，並安排門診追蹤。 |
| D | 22. | 42 歲男性，在家清潔浴室時，意外濺入強鹼性清潔劑到左眼。他立即以自來水沖洗 10 分鐘後到達急診室。急診醫師檢查時發現患者左眼嚴重充血、水腫，角膜呈現輕度混濁，測得眼內 pH 為 8.0。下列處置何者較適當？<br>（A）以生理食鹽水沖洗 15 分鐘後，給予局部抗生素藥膏，並 24 小時內轉診眼科。<br>（B）以 500 mL 生理食鹽水持續沖洗後，測量眼壓評估是否有青光眼風險。<br>（C）以生理食鹽水沖洗 15 分鐘後，給予局部類固醇藥物以減少發炎反應。<br>（D）以生理食鹽水持續沖洗，直至眼內 pH 恢復至 7.4 並穩定 30 分鐘後，進行詳細眼部檢查。 |

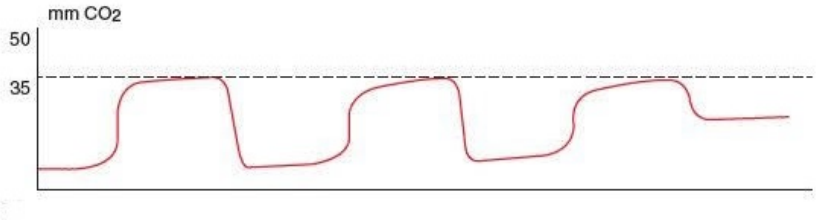
# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 23. | 45 歲女性，近期因骨折接受手術，術後 10 天因突發性呼吸困難與胸痛至急診就醫。血壓 85/55 mmHg，心跳 115 次/min，呼吸 28 次/min，血氧 89%。CT 肺血管攝影證實肺動脈栓塞。下列治療方式何者較適當？<br>（A）低分子量肝素（Low-molecular-weight heparin）皮下注射治療 5 天後改為 Warfarin。<br>（B）立即靜脈注射 Amiodarone 控制心率，再決定是否抗凝治療。<br>（C）由於血壓偏低，應立即考慮靜脈注射，或導管介入性血栓溶解治療（thrombolysis）。<br>（D）直接使用 NOAC，如 Rivaroxaban 作為第一線抗凝治療。 |
| C | 24. | Salter-Harris III 型骨折最常影響踝關節的哪個部位？<br>（A）遠端腓骨。<br>（B）距骨。<br>（C）脛骨前外側。<br>（D）跟骨。 |
| B | 25. | 62 歲男性過去有心肌梗塞病史，因極度虛弱、呼吸困難和意識改變來急診。生命徵象：血壓 76/50 mmHg、心跳 118 次/min、呼吸 24 次/min、血氧飽和度 94%、體溫 36.5°C，身體診察發現皮膚冰冷、頸靜脈怒張。床邊超音波顯示 LVEF 嚴重降低至 25%，並有 apical hypokinesis。心電圖顯示 V2-V4 導程的 ST 段升高。儘管初始輸注 500 mL 生理食鹽水，病人仍持續低血壓。下列治療何者較適當？<br>（A）再次輸注 1L 生理食鹽水。<br>（B）開始 Norepinephrine 靜脈輸注。<br>（C）靜脈給予 Metoprolol 控制心率。<br>（D）開始 Sodium Nitroprusside 靜脈輸注。 |
| C | 26. | 出生第 5 天的足月新生兒，病嬰出現發燒、黃疸、活動力下降及呼吸急促。懷疑新生兒可能有敗血症（neonatal sepsis），針對抗生素的選擇，下列何者應該避免使用？<br>（A）Ampicillin。<br>（B）Gentamicin。<br>（C）Ceftriaxone。<br>（D）Cefotaxime。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| D | 27. | 20 歲男性，因右側頸部腫塊 2 週至急診求診，無發燒、體重減輕或盜汗病史。身體診察發現右頸前部有一約 2 公分、無痛性腫塊，無壓痛，觸感中等硬度。超音波顯示邊界清楚的腫塊。頸部電腦斷層檢查顯示囊性病灶，無鈣化。下列何者為較可能的診斷？<br>（A）反應性淋巴結腫大（Reactive lymphadenopathy）。<br>（B）轉移性頭頸部鱗狀細胞癌（Metastatic aerodigestive tract carcinoma）。<br>（C）甲狀腺腫瘤（Thyroid neoplasm）。<br>（D）甲狀舌管囊腫（Thyroglossal duct cyst）。 |
| C | 28. | 關於次發性氣胸的可能成因，下列何者較不常見？<br>（A）human immunodeficiency virus infection。<br>（B）sarcoidosis。<br>（C）mitral valve prolapse。<br>（D）scleroderma。 |
| A | 29. | 2 歲男童服用鐵粉食品乾燥劑，1 小時前曾有頻繁嘔吐，較為嗜睡，心跳 130 次/min，血壓 85/50 mmHg，呼吸 28 次/min。檢驗數據如下：血清鐵濃度（Serum Iron）4 小時後測得 530 μg/dL（正常值：50~170 μg/dL）、動脈血氣分析：pH 7.28，$HCO_3^-$ 16 mEq/L，Lactate 5 mmol/L、凝血功能：PT/INR 延長，D-dimer 上升、腹部 X 光顯示胃內有多數散狀放射不透物質。下列處置何者較適當？<br>（A）立即靜脈輸注 Deferoxamine 並進行全腸道灌洗（whole-bowel irrigation）。<br>（B）口服活性碳以吸附鐵並降低腸胃道吸收。<br>（C）進行血液透析以移除過量的血清鐵。<br>（D）立即進行胃灌洗，並給予維生素 K 逆轉凝血異常。 |
| D | 30. | 3 週大的新生兒因發燒 39.2℃、嗜睡及反應遲鈍來急診。醫師決定執行腰椎穿刺以評估細菌性腦膜炎的可能性。關於腰椎穿刺的技術，下列敘述何者較適當？<br>（A）四週以下的嬰兒，需注意腦脊髓液的 Protein 正常值範圍較低。<br>（B）針刺點應選擇 L2~L3 間。<br>（C）進針時最好選擇側臥，並讓髖部及頸部儘量屈曲（hip and neck flexion）。<br>（D）建議使用 22 號（22G）針。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| A | 31. | 根據病人的二氧化碳波形（capnography）如圖所示，下列何者較可能是病人的呼吸問題？<br>  <br><br>（A）氣道塌陷（airway collapse）。<br>（B）急性肺栓塞（acute pulmonary embolism）。<br>（C）過度換氣（hyperventilation）。<br>（D）肺順應性降低（reduced lung compliance）。 |
| A | 32. | 45 歲男性，3 週前接受異體造血幹細胞移植（hematopoietic stem cell transplantation），因突然發燒，體溫 39.2℃、皮膚紅疹與腹瀉至急診。身體診察發現全身紅疹（主要分布於手掌、腳底與軀幹），腹部輕微壓痛但無反彈痛。血液檢查發現白血球 3,000 /μL，血小板 95,000 /μL，AST 120 U/L，ALT 135 U/L，Total bilirubin 2.1 mg/dL。較可能的診斷為何？<br>（A）急性移植物抗宿主疾病（Acute graft-versus-host disease）。<br>（B）巨細胞病毒（Cytomegalovirus）感染。<br>（C）藥物過敏反應。<br>（D）移植後淋巴增生性疾病（Post-transplant lymphoproliferative disorder）。 |
| C | 33. | 35 歲男性左小腿砸傷，劇烈疼痛且在被動伸展腳踝時加劇。左小腿前側明顯腫脹、觸診時肌肉緊繃，並有壓痛，無開放性傷口，腳趾有輕微麻木感，足背動脈搏動正常。下列處置何者較適當？<br>（A）立即安排住院，給予止痛藥，並等待筋膜壓力測量結果。<br>（B）進行小腿 X 光與超音波檢查以排除骨折與深部血栓。<br>（C）立即測量筋膜腔室壓力，並準備緊急筋膜切開術。<br>（D）給予抗生素和止痛藥，並建議病人抬高患肢休息。 |
| D | 34. | 35 歲男性因機車車禍至急診，表示左足無力。檢查發現左小腿近端前外側有一道 5 公分撕裂傷，傷口乾淨無異物，評估遠端肢體循環正常，但左足無法背屈（dorsiflexion）。下列臨床表現何者較不可能？<br>（A）小腿外側感覺正常。<br>（B）足部感覺異常只侷限在第 1 與第 2 趾間。<br>（C）足部可以執行外翻（eversion）。<br>（D）第 1 趾可以執行伸展（extension）。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| B | 35. | 手肘及前臂受傷無法屈曲拇指與食指比 OK 手勢，較可能發生下列何種神經損傷？<br>（Ａ）尺神經損傷（ulnar nerve injury）。<br>（Ｂ）前骨間神經損傷（anterior interosseous nerve injury）。<br>（Ｃ）後骨間神經損傷（posterior interosseous nerve injury）。<br>（Ｄ）橈神經損傷（radial nerve injury）。 |
| C | 36. | 1 歲幼童 3 天前確診流感已服用克流感藥物，出生後疫苗皆按時施打，今日因持續高燒、咳嗽、呼吸急促及膿痰就醫，胸部 X 光顯示左側肺炎合併肋膜積水。後續處置何者較適當？<br>（Ａ）鼻咽部（nasopharyngeal）細菌培養能提供抗生素用藥參考。<br>（Ｂ）應考慮 *Staphylococcus aureus* 造成的次發性細菌性肺炎，其病情進展較緩慢但容易產生肺膿瘍。<br>（Ｃ）首選抗生素為 β-lactam 類抗生素如 Ampicillin。<br>（Ｄ）感染進展為膿胸（empyema）時，β-lactam 類抗生素仍為首選。 |
| D | 37. | 32 歲男性無慢性病史，1 小時前在台東山區工作時被不明蛇種咬傷左前臂，來診時患部腫脹瘀青，抽血檢測 BUN 62 mg /dL、Creatinine 4.2mg /dL、PT 28 sec、aPTT 51 sec，下列血清何者較適合為病人施打？<br>（Ａ）抗出血性蛇毒血清。<br>（Ｂ）抗神經性蛇毒血清。<br>（Ｃ）抗百步蛇蛇毒血清。<br>（Ｄ）抗鎖鏈蛇蛇毒血清。 |
| C | 38. | 55 歲男性，因氣喘發作來到急診，已經接受高流量氧氣、Albuterol 霧化治療、靜脈注射 Methylprednisolone 40 mg、Magnesium Sulfate 2 g。目前生命徵象：呼吸 40 次/min，仍有喘鳴（wheezes）、心跳 135 次/min、血壓 160/95 mmHg、$SpO_2$ 88%。下列藥物選擇何者較適合？<br>（Ａ）靜脈輸注 Aminophylline 5 mg/kg，維持輸注 0.5 mg/kg/hr。<br>（Ｂ）靜脈輸注 Epinephrine 0.5 mg/kg/hr，緩慢滴注。<br>（Ｃ）靜脈輸注 Ketamine 0.15 mg/kg stat，維持輸注 0.25 mg/kg/hr 。<br>（Ｄ）靜脈輸注 Montelukast 10 mg。 |

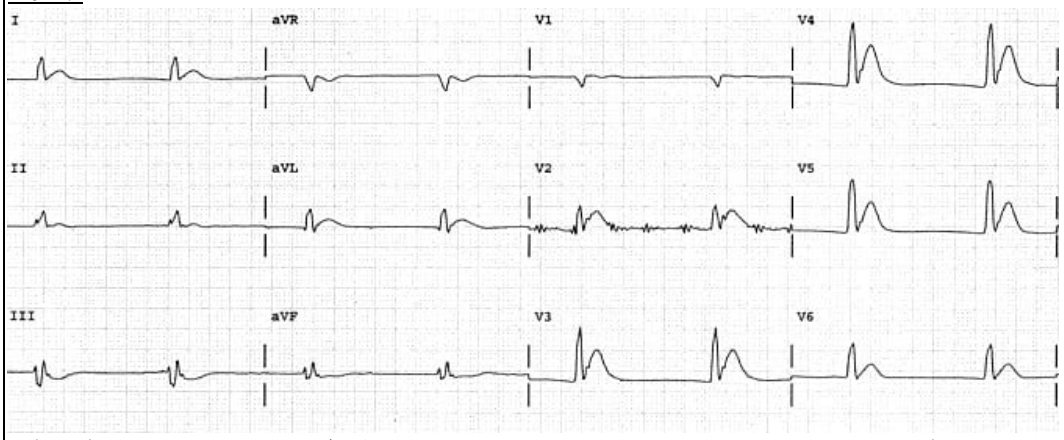
# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| B | 39. | 於急診評估疑似精神疾患時，以下何種表現較可能暗示此病人症狀非單純精神疾患表現？<br>（A）26 歲女性，最近聽幻覺持續。<br>（B）10 歲男孩初次發作視幻覺，父母帶來就醫。<br>（C）思覺失調症患者未規律服藥，在路邊吼叫由 119 送來。<br>（D）36 歲男子常自言自語，近來夜間無法入睡，於街頭遊蕩而被送醫。 |
| B | 40. | 工人被生鏽金屬棒刺穿前臂，5 小時後就醫。傷口內有泥沙，X 光無骨折或異物留存。關於傷口的縫合方式，下列何者較適當？<br>（A）清創沖洗後立即縫合傷口。<br>（B）延遲 72~96 小時之後，縫合傷口。<br>（C）縫合傷口後，給予口服抗生素。<br>（D）會診外科醫師縫合傷口，安排隔天門診追蹤。 |
| B | 41. | 68 歲男性，有糖尿病及慢性阻塞性肺病病史，因咳嗽、發燒、胸痛至急診就醫。胸部 X 光顯示右下肺有一空洞性病變，CT 顯示肺部膿瘍並懷疑膿胸。下列抗生素選擇何者較適當？<br>（A）Ceftriaxone + Azithromycin。<br>（B）Piperacillin-Tazobactam（Tazocin®）。<br>（C）Vancomycin + Linezolid。<br>（D）Ciprofloxacin + Metronidazole。 |
| D | 42. | 18 個月大的女童，被發現 3 天前開始出現發燒、躁動不安和尿量減少。來急診就醫後，通過導尿初步 urinalysis 顯示 8~10 WBCs /HPF、negative leukocyte esterase，和 negative nitrites。6 小時後，實驗室來電報告尿液培養生長兩種不同的微生物。她的發燒持續在 39.8℃，且看起來更嗜睡。下列處置何者較適當？<br>（A）給予口服抗生素並密切追蹤後出院，尿液培養可能被汙染。<br>（B）獲取新的導尿樣本，因為目前的結果不足以診斷泌尿道感染。<br>（C）開始靜脈抗生素治療並收治住院，等待最終培養結果。<br>（D）開始靜脈抗生素治療並立即安排腎臟超音波檢查。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 43. | 45 歲男性，近期自東南亞返台，主訴過去 1 個月有漸進性咳嗽、體重減輕與夜間盜汗。來院時生命徵象穩定。胸部 X 光顯示右上肺有空洞性病灶。下列處置之敘述何者較適當？<br>（A）痰液抗酸性染色（AFB smear）對於診斷之敏感性之特異性均佳。<br>（B）痰液培養結果確認後，始可進行治療。<br>（C）將病人先安置在隔離區並戴上口罩。<br>（D）核酸擴增檢驗（Nucleic Acid Amplification Test）敏感性較 AFB smear 差。 |
| D | 44. | 關於神經學檢查，下列何者較適當？<br>（A）可以透過手的伸展，來測試正中神經的部分運動功能。<br>（B）可以透過髖部的伸展來測試股神經的部分運動功能。<br>（C）可以透過近端指節（PIP）的伸展與屈曲來測試橈神經的部分運動功能。<br>（D）可以透過手指的內收和外展來測試尺神經的部分運動功能。 |
| C | 45. | 6 歲男童有水腦（hydrocephalus）病史，3 年前接受腦室腹腔分流管（VP shunt）手術。近 2 天出現嘔吐、嗜睡及間歇性頭痛，至急診就醫。父母回報這幾週偶有類似頭痛，最近拍照時發現小孩常呈「眼白過多」的下視樣貌（sundowning sign）。病童生命徵象：體溫 37.7℃，心跳 102 次/min，血壓 108/68 mmHg，呼吸 22 次/min。意識狀態較遲鈍但可喚醒，無局部神經學異常，分流管傷口處未見紅腫或分泌物。下列處置何者較適當？<br>（A）安排腰椎穿刺及腦脊髓液培養，以評估是否有腦膜炎。<br>（B）立即給予廣效性抗生素，並安排腰椎穿刺與腦部影像檢查。<br>（C）安排腦部電腦斷層及分流管系列 X 光檢查。<br>（D）安排床邊腦部超音波初步評估，若穩定則安排門診追蹤。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 46. | 65 歲女性，診斷為轉移性乳癌（metastatic breast cancer），近日出現疲倦、食慾下降及便秘，並主訴噁心與口渴。心電圖如圖，下列初始處置何者較適當？<br>  <br><br>（A）立即啟動心導管團隊，進行冠狀動脈介入治療術（percutaneous coronary intervention）。<br>（B）給予葡萄糖酸鈣（Calcium Gluconate）及碳酸氫鈉（Sodium Bicarbonate）。<br>（C）注射降鈣素（Calcitonin）及靜脈輸注生理食鹽水（IV normal saline infusion）。<br>（D）給予雙磷酸鹽（Bisphosphonates）及環形利尿劑（Loop diuretics）。 |
| A | 47. | 急診醫師在執行中心靜脈導管放置時，意外遭受留置針刺傷。該病人有 HIV 感染病史，最近一次病毒載量檢測為 1,000 copies/mL，不規則使用抗逆轉錄病毒療法。醫師立即以肥皂與清水沖洗傷口。根據 CDC 及 OSHA 的指引，以下哪一項是對該醫師較適當的處置方式？<br>（A）開始三聯抗逆轉錄病毒療法（Three-drug Postexposure Prophylaxis (PEP) regimen），並於 72 小時內接受專家評估。<br>（B）進行醫師的 HIV 初始檢測，若 4 週後仍為陰性，則不需額外處理。<br>（C）由於病人 HIV 病毒載量高，應住院觀察並開始四聯抗逆轉錄病毒療法（Four-drug PEP regimen）。<br>（D）由於暴露風險低，應於 4 週後再次檢測 HIV，若為陽性才開始 PEP。 |
| D | 48. | 58 歲男性，突發大量咳血併呼吸困難，過去 24 小時內咳出約 600 mL 血液。經緊急氣道處理後，仍有大量出血且生命徵象不穩定，應立即進行下列哪項處置較適當？<br>（A）安排外科手術。<br>（B）進行支氣管鏡檢查並進行局部治療。<br>（C）使用腎上腺素霧化治療與靜脈注射 Tranexamic acid。<br>（D）進行支氣管動脈栓塞術（bronchial artery embolization）。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 49. | 18 歲男性突發性呼吸急促，體溫 36.8℃，血壓 120/90 mmHg，呼吸 28 次/min，心跳 130 次/min，血氧濃度為 98%，胸腔 X 光發現右側氣胸，下列治療何者較適當？<br>（A）此病人為穩定的氣胸。<br>（B）若 X 光上肺尖至壁層肋膜頂距離為 4 公分，可先給予氧氣，觀察 3 小時。<br>（C）若要使用針刺減壓，選用 14 gauge 針頭，入針位置為前腋線第四肋間。<br>（D）若針刺減壓後病人立刻呼吸困難，要考慮 reexpansion lung injury，應立刻拔掉引流管。 |
| A | 50. | 68 歲男性，平日住在家中，有糖尿病病史。因發燒、呼吸困難及意識改變至急診就診。生命徵象：體溫 38.9℃，心跳 115 次/min，呼吸 28 次/min，血壓 85/50 mmHg，血氧 87%。胸部 X 光顯示右下肺葉浸潤。WBC 18,000 /μL，Lactate 3.2 mmol/L，Creatinine 1.8 mg/dL。最合適的經驗性抗生素組合為何？<br>（A）Ceftriaxone + Azithromycin + Levofloxacin + Vancomycin。<br>（B）Meropenem + Doxycycline。<br>（C）Ceftazidime + Levofloxacin + Vancomycin + Fluconazole。<br>（D）Vancomycin + Metronidazole。 |
| B | 51. | 19 歲男性，主訴喉嚨痛 5 天，合併吞嚥困難及頸部腫脹。體溫 38.8℃、聲音改變（muffled voice），但呼吸平順、無咳嗽或流鼻水。身體診察發現咽喉嚴重紅腫，扁桃體有膿性分泌物，並有頸部壓痛性腫脹。鏈球菌快速抗原檢測陽性。安排頸部側位 X 光檢查（lateral neck X-ray），發現 retropharyngeal space 擴大。下列治療處置何者較適當？<br>（A）口服 Amoxicillin-Clavulanate 10 天，門診追蹤。<br>（B）肌肉注射 Benzathine Penicillin G 1.2 million units，並安排頸部 CT 進一步評估。<br>（C）會診耳鼻喉科，進行緊急氣管插管。<br>（D）病人為 Group A β-hemolytic Streptococcus，應使用 Metronidazole 為第一線治療。 |

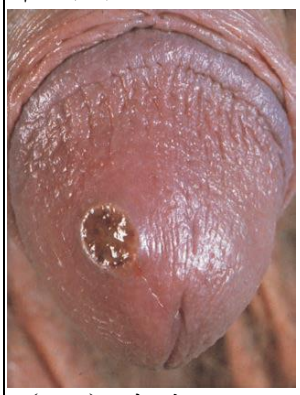
# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| A | 52. | 28 歲女性，由家屬陪同，主訴頭暈與胸悶，無明顯外傷。病人既往無重大病史，說話細聲顫抖，對生活與健康狀況避重就輕。身體診察發現右手腕有舊瘀傷、左肩有新形成的指壓狀瘀青，乳房下方有多處癒合疤痕，生命徵象穩定。問病史時，她語帶恐懼地說：「我不敢說太多，不然他會生氣...」此時，較適當的下一步是？<br>（A）使用篩檢親密伴侶暴力表單詢問。<br>（B）告知家屬因高度懷疑病人受暴力攻擊，需進一步詢問。<br>（C）記錄傷勢及其成因，病歷需註明「依病人所述」等字樣釐清後續法律問題。<br>（D）向家屬說明會通報社工。 |
| C | 53. | 48 歲男性確診為開放性肺結核，使用第一線抗結核藥物進行治療後，抱怨最近出現視力模糊。下列何種藥物較有可能導致此症狀？<br>（A）Rifampin。<br>（B）Isoniazid。<br>（C）Ethambutol。<br>（D）Pyrazinamide。 |
| B | 54. | 70 歲女性因跌倒頭部外傷，腦部電腦斷層顯示有輕度顱內出血，過去有非瓣膜性心房顫動病史，正在規則使用 Rivaroxaban。病人無其他明顯出血症狀，生命徵象穩定。下列關於此病人急診反轉抗凝策略的選項何者較適當？<br>（A）立即給予 Idarucizumab 可專一性反轉 Rivaroxaban。<br>（B）使用代替反轉劑 4-factors prothrombin complex concentrate（PCC），可用於 Rivaroxaban 的反轉。<br>（C）改用 Enoxaparin 作為抗凝替代藥物，以減少顱內出血風險。<br>（D）Protamine sulfate 為首選藥物，因其可中和所有抗凝血劑。 |
| C | 55. | 在無症狀病人中，初次血液培養報告為陽性時，培養出以下哪一種菌最有可能代表真正的菌血症，需要針對個別病人重新評估？<br>（A）*Corynebacterium species*。<br>（B）*Bacillus species*。<br>（C）*Coagulase-negative Staphylococcus*。<br>（D）*Propionibacterium acnes*。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 56. | 55 歲男性，因胸痛至急診就醫。病人表示胸痛為壓迫感，伴隨噁心與冷汗，休息後未見改善。心電圖顯示無 ST 段變化，首次 troponin 為陰性。下列急診處置何者較適當？<br>（A）首次 troponin 陰性，可直接排除急性冠心症，離院回家。<br>（B）立即安排心導管檢查，以評估是否需行氣球擴張術或支架置放。<br>（C）觀察並於 2~3 小時後重測 troponin，並根據 HEART Pathway 風險評估。<br>（D）給予 Aspirin 100 mg，再安排心臟運動壓力檢查（treadmill exercise test）。 |
| A | 57. | 青少年誤食野生植物，出現意識混亂、譫妄、視力模糊、口乾舌燥、心悸及排尿困難至急診。皮膚乾燥潮紅、瞳孔擴大、心跳過快，出現陣發性肢體抽搐表現，心電圖為寬 QRS 波之心搏過速。下列敘述何者較不適當？<br>（A）可用碳酸氫鈉治療，也可用 IA 類抗心律不整藥物。<br>（B）鎮靜不足可能導致高熱加重或延長、橫紋肌溶解和外傷。<br>（C）攝入毒性物質 1 小時內可使用活性碳進行胃腸道除污。<br>（D）考慮使用 Physostigmine 來治療嚴重激動和譫妄。 |
| A | 58. | 關於 acute psychoses 與 acute delirium 的敘述何者較適當？<br>（A）前者的病程較為漸進式或亞急性、後者的病程較為急性突發且會時好時壞（fluctuating）。<br>（B）前者的臨床症狀主要是視幻覺、後者則主要是聽幻覺，但兩者皆表現空間時間定向感障礙。<br>（C）前者較常表現出面部表情僵硬及肌肉僵直行動遲緩的狀態，後者較常表現出躁動的情況。<br>（D）皆可能與酒精有關，但前者為酒精中毒（intoxication）所致，後者為酒精戒斷（withdrawl）所致。 |
| B | 59. | 65 歲女性，突發左側肢體無力和步態異常，症狀於 2 小時前開始。檢查發現左側肢體肌力 4/5，左下肢共濟失調，腱反射對稱，無意識改變。頭部電腦斷層掃描未見腦出血，但發現腦室輕度擴大。下列診斷何者較適當？<br>（A）小腦梗塞。<br>（B）大腦半球梗塞。<br>（C）正常壓力水腦。<br>（D）脊髓後柱病變。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| A | 60. | 25 歲男性，因機車事故撞擊胸部，送至急診時呈現呼吸急促、頸靜脈怒張、氣管偏移、右側胸廓擴張且無呼吸音，血壓 80/50 mmHg，心跳 130 次/min。下列處置何者較適當？<br>（A）立即行針刺減壓（needle decompression），隨後置入胸管。<br>（B）先以高流量氧氣治療，然後再評估是否進一步減壓。<br>（C）立即給予支氣管擴張劑以改善通氣。<br>（D）進行經皮氣管造口術（percutaneous tracheostomy）以改善呼吸困難。 |
| B | 61. | 24 歲男性因陰莖潰瘍疼痛 5 天至急診就診，傷口如圖所示，鼠蹊部可觸及單側淋巴結腫大及疼痛。下列敘述何者較適當？<br>  <br>（A）考慮 *Haemophilus ducreyi* 感染，使用 Penicillin G 2.4 million units IM 治療。<br>（B）可考慮淋巴結切開引流以緩解疼痛。<br>（C）使用藥物治療後 24 小時內常見發燒、頭痛、肌肉痠痛，稱為 Jarisch-Herxheimer reaction。<br>（D）若伴侶於過去 10 天內有性行為接觸但無臨床症狀，可先觀察，不須立即給予治療。 |
| D | 62. | 男性外生殖器外傷的處置，下列敘述何者較不適當？<br>（A）陰莖穿刺傷常合併尿道損傷，懷疑時須安排逆行性尿道攝影。<br>（B）陰莖骨折主要為臨床診斷，超音波可以作為輔助診斷的工具。<br>（C）陰囊與睪丸外傷的診斷工具，主要為彩色都普勒超音波。<br>（D）陰囊穿刺傷經彩色都普勒超音波檢查後正常，可進行陰囊縫合手術。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 63. | 65 歲男性，數月來進食時有吞嚥困難，起初僅限於固體食物，近期連液體也有困難，並伴隨吞嚥時胸骨後不適（odynophagia）。病人無慢性疾病史，亦無胃食道逆流病史。下列哪一項是造成其吞嚥困難較適當的原因？<br>（A）口腔癌（oral cancer）。<br>（B）吞嚥失調（oropharyngeal dysphagia）。<br>（C）食道癌（esophageal carcinoma）。<br>（D）Zenker's 憩室（Zenker's diverticulum）。 |
| B | 64. | 45 歲男性，右髖部疼痛，疼痛在坐姿或爬樓梯時加重，身體診察發現右側臀部有觸痛性腫塊（tender mass），且髖關節屈曲與內旋時症狀惡化。下列診斷何者較適當？<br>（A）大轉子滑囊炎（trochanteric bursitis）。<br>（B）梨狀肌症候群（piriformis syndrome）。<br>（C）閉孔神經卡壓（obturator nerve entrapment）。<br>（D）髂腹股溝神經卡壓（ilioinguinal nerve entrapment）。 |
| B | 65. | 68 歲男性，有 COPD 病史，近期因呼吸困難惡化、虛弱嗜睡被送至急診。$SpO_2$ 85%、呼吸 30 次/min、明顯呼吸費力、肺音減弱。下列處置何者較適當？<br>（A）給予 non-rebreathing mask，維持 $SpO_2 \geq 95\%$。<br>（B）可考慮給予非侵襲性雙相正壓通氣（BiPAP），並密切監測 pH 與 $CO_2$ 變化。<br>（C）可靜脈輔助給予 theophylline 以改善呼吸困難與呼吸肌疲乏。<br>（D）急性 COPD 惡化應給予廣效性抗生素，以預防併發感染。 |
| C | 66. | 56 歲男性農夫，無過去病史，連續 10 天發燒、頭痛、肌肉痠痛來急診。近日曾在大雨後清理稻田，經常接觸積水區域，家中飼養豬隻。身體診察發現輕微黃疸、結膜充血、下肢壓痛，無皮疹或淋巴結腫大。該病人的診斷及治療何者較適當？<br>（A）登革熱（Dengue fever），支持性療法。<br>（B）恙蟲病（Scrub typhus），抗生素選用 Ceftriaxone 每天 2 g，連續 7 天。<br>（C）鉤端螺旋體病（Leptospirosis），Doxycycline 100 mg 每天 2 次，連續 7 天。<br>（D）布氏桿菌病（Brucellosis），Doxycycline + Rifampin 連續 7 天。 |

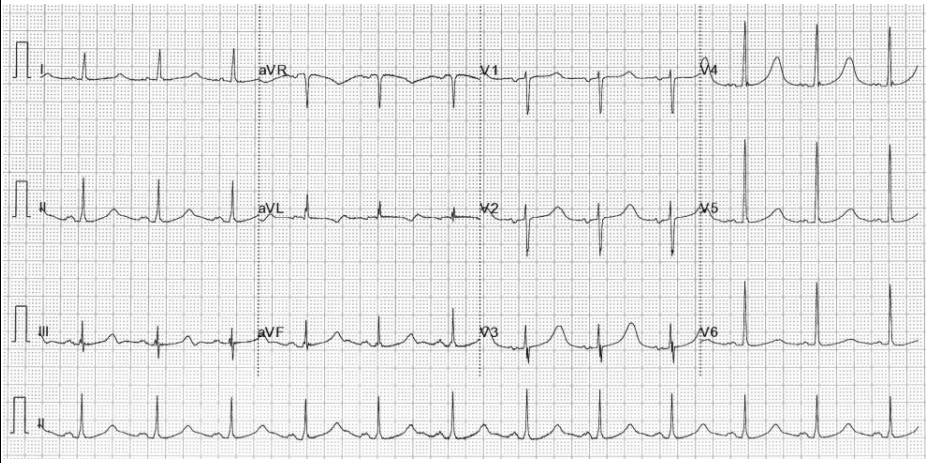
# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 67. | 35 歲男性在核電廠輻射事故後 2 小時送來急診室。無症狀但輻射劑量超出背景值 50 rem/y 以上。生命徵象穩定，無可見的外傷。下一步處置何者較適當？<br>（A）協助體外除汙後安排病人出院，並預約 3 日內職業醫學科門診追蹤。<br>（B）預防性給予碘化鉀，留院觀察追蹤。<br>（C）檢驗全血球計數與絕對淋巴球計數，留院觀察追蹤。<br>（D）給予廣效抗生素及白血球生長激素（G-CSF），收治隔離病房。 |
| C | 68. | 25 歲男性，有第一型糖尿病病史，近 3 天未規律施打胰島素，現有發燒及腹痛。血壓 100/60 mmHg，心跳 120 次/min，呼吸 28 次/min，血糖 450 mg/dL，動脈血氣顯示 pH 7.15，$HCO_3^-$ 10 mEq/L。下列哪一項為較適當的初始處置？<br>（A）抽血發現鉀離子為 $K^+$ 4.0 mEq/L，無須補充鉀離子。<br>（B）先給予靜脈注射 Bicarbonate 以矯正酸中毒。<br>（C）先給予 20 ml/kg 靜脈輸注生理食鹽水。<br>（D）先給予 IV bolus 胰島素以控制血糖。 |
| D | 69. | 65 歲女性，主訴 1 小時前突然胸悶全身虛弱，心電圖看到 II、III、aVF ST 段上升與右側心前極導 RV4-6 ST 段微幅上升。下列敘述何者較適當？<br>（A）這類病人臨床上常合併 sinus tachycardia 與 atrial fibrillation 的心律變化。<br>（B）病人在處理過程中發生短暫的 ventricular tachycardia，為不良的預後因子。<br>（C）這類心肌梗塞較常見的機械式併發症（mechanical complication）是心室中膈破損（rupture of interventricular septum）。<br>（D）若此時病人合併喘及急性肺水腫的表現，較不可能是急性僧帽瓣逆流（mitral valve regurgitation）所致。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| B | 70. | 8 個月大男嬰因 3 天來咳嗽、流鼻水、鼻塞及食慾下降至急診就醫。父母表示男嬰出生時健康，無慢性疾病病史。身體診察發現鼻翼煽動（nasal flaring）、雙肺廣泛喘鳴音（wheezing）、輕微肋間凹陷（intercostal retractions），下列敘述何者較適當？<br>（A）此男嬰最可能的感染源是副流感病毒（parainfluenza virus）。<br>（B）吸入性的支氣管擴張劑如 salbutamol/albuterol 並不能改善血氧（oxygen saturation），住院率以及住院天數。<br>（C）吸入性的腎上腺素（epinephrine）可以降低此類病人住院率，在嚴重的個案可以考慮使用。<br>（D）High-flow nasal cannula 因微弱的吐氣末期正壓（positive end expiratory pressure）可能造成分泌物阻塞，不可使用於 1 歲以下嬰兒。 |
| B | 71. | 28 歲男性，過去有未治療的 HIV 感染（近日門診抽血顯示 CD4 計數 120/μL），平日有大量吸菸與飲酒習慣，因牙齦劇烈疼痛、自發性出血、口中惡臭且帶有金屬味來到急診。病人表示近 1 週進食及刷牙困難，並自述 1 年前曾有唇部皰疹發作紀錄。身體診察發現：體溫 38.1℃，心跳 96 次/min，血壓 112/72 mmHg。口腔檢查顯示：齒間乳突呈打孔狀潰瘍（punched-out interdental papillae）、覆蓋灰白色偽膜、牙齦出血與口臭明顯。舌背與硬顎未見白色斑塊或潰瘍，雙側下頷淋巴結腫大且壓痛。無牙關緊閉（trismus）。下列初步處置何者較適當？<br>（A）給予口服 Acyclovir 並建議每日鹽水漱口。<br>（B）給予口服 Metronidazole 並建議以 Chlorhexidine 漱口。<br>（C）安排門診牙科評估以進行牙周局部清創處置。<br>（D）給予靜脈注射 Vancomycin 並安排感染科會診住院觀察。 |
| A | 72. | 50 歲男性疑似遭受生物恐怖攻擊，12 天後出現高燒、劇烈肌肉痠痛與極度倦怠。隨後臉部出現紅色丘疹，並迅速擴展至四肢及軀幹，包括手掌與腳底。皮疹從水泡轉變為膿皰，最終形成結痂。接觸者中已有多人出現類似症狀。下列處置何者較適當？<br>（A）針對發病者給予支持性治療。<br>（B）給予抗生素 Ciprofloxacin 或 Doxycycline 進行經驗性治療。<br>（C）盡快給予暴露者炭疽疫苗（anthrax vaccine）作為預防。<br>（D）啟動全民天花疫苗（vaccinia vaccine）接種，防止疫情擴散。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| D | 73. | 29 歲男性病人有 HIV 病史，因斷續發燒 5 天合併有咳嗽症狀至急診就醫，經 X 光檢查發現肺部感染，下列敘述何者較適當？<br>（A）HIV 病人的肺炎以細菌性肺炎為大宗，最常見菌種是黃金色葡萄球菌（*Staphylococcus aureus*）。<br>（B）若胸部 X 光發現有肋膜積液，僅需考慮細菌性感染的可能。<br>（C）當 CD4+ T 細胞計數介於 250~500 cells/μL 時，要考慮肺囊蟲肺炎（*Pneumocystis jirovecii* pneumonia）伺機性感染。<br>（D）細菌性肺炎比肺囊蟲肺炎發生率高。 |
| D | 74. | 40 歲男性高處墜落，血壓 68/38 mmHg、心跳 138 次/min、呼吸 28 次/min、GCS 9。左大腿開放性骨折合併大量出血，救護人員已使用止血帶，給予 1,000 mL Ringer's lactate 後未改善。創傷床邊超音波（eFAST）未見胸腹腔內出血，胸部 X 光未見明顯血胸。初步評估無明顯軀幹出血。下一步處置何者較適當？<br>（A）嘗試進行止血帶替換，並加壓包紮傷口以減少組織缺血風險。<br>（B）安排腹部與骨盆電腦斷層以確認是否有延遲性內出血。<br>（C）插入 REBOA 並置於 Zone 3 以作為出血性休克的暫時控制措施。<br>（D）啟動大量輸血流程，同步給予紅血球、血漿與血小板（1:1:1）。 |
| B | 75. | 25 歲男性於運動時短暫失去意識約 30 秒被送至急診。於急診時生命徵象正常，目前沒有服用任何藥物，表示過去也有幾次類似情況發生，心電圖如下，初步抽血 Hb 14 g /dL，WBC 5,000 /μL，Na 140 meq/L，K 4.0 meq/L，Ca 9.0 mg /dL，Mg 2.0 mg /dL。下列處置何者較適當？<br>  <br>（A）考慮給予胺碘酮（Amiodarone）。<br>（B）考慮給予乙型阻斷劑（β-blocker）。<br>（C）考慮給予硫酸鎂（$MgSO_4$）。<br>（D）考慮放置心律調節器（permanent pacemaker）。 |

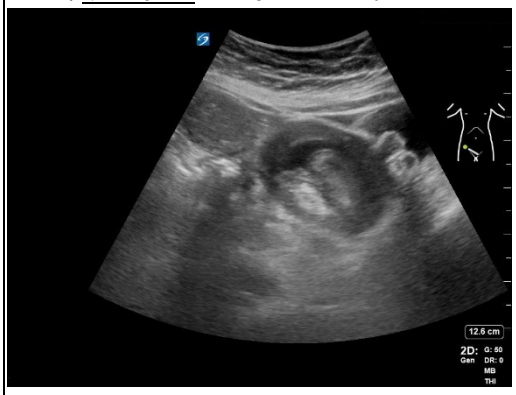
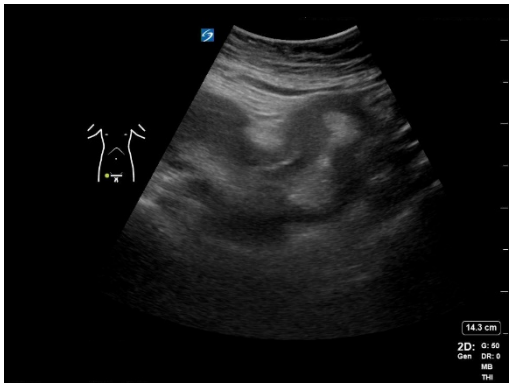
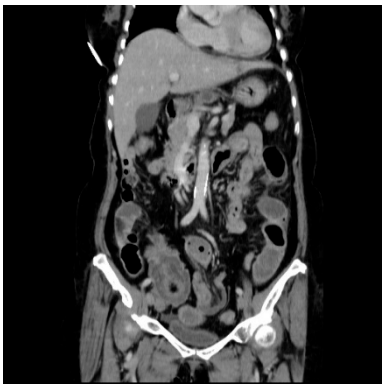
# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| A | 76. | 關於兒童整流及去顫電擊，下列何者較不適當？<br>（A）若發生心室顫動，雙相設備去顫能量為 2~4 J/kg，單相設備去顫能量為 4~8 J/kg。<br>（B）若為有脈搏的心室心搏過速，同步電擊整流起始能量為 1 J/kg，必要時逐步增加至 4 J/kg。<br>（C）成人自動體外去顫器（AED）可用於 8 歲及以上兒童；部分 AED 配有兒童貼片，可用於 1 歲及以上兒童。<br>（D）嬰兒患者可側躺，電擊貼片採用前後位置（anteroposterior）放置。 |
| A | 77. | 大型活動醫療準備措施，下列敘述何者較不適當？<br>（A）確保足量的靜脈輸液，以應對可能出現之大量脫水病人。<br>（B）若無法連接周圍醫療資源，須制定相關流程，確保能夠聯繫並傳遞信息。<br>（C）配備自動體外心臟去顫器（AED）以應對可能之心肺停止。<br>（D）紙本醫療紀錄文件理想上應為單頁設計，便於所有醫療人員共同使用。 |
| C | 78. | 68 歲女性，因急性幻覺、妄想與語無倫次被帶來急診，過去病史不明。若要使用抗精神病藥物做急性的鎮靜處理，下列敘述何者較適當？<br>（A）Haldol 為高效價（high potency）的抗精神病藥物，相較於低效價的藥物較不易產生錐體外症候群，為首選用藥。<br>（B）年長病人應優先考慮第二代抗精神病藥物，相較於第一代抗精神病藥物，治療效果較佳且不會有錐體外症候群的發生。<br>（C）病人用藥後出現頸部僵硬、眼睛上吊的現象，若給予 Biperiden 無效或復發，應考慮給予 Benzodiazepine。<br>（D）Haldol 有心血管的影響，會抑制心肌的鉀離子通道造成 QTc 延長引發 tosrades de pointes，且較容易引起低血壓。 |
| C | 79. | 58 歲男性，突發性劇烈眩暈、走路搖晃與持續性嘔吐，無耳鳴或聽力喪失。初步臆斷為「前庭神經炎」。關於臨床判斷與處置，下列何者較適當？<br>（A）所有眩暈病人皆應接受 HINTS（Head Impulse-Nystagmus-Test of Skew）檢查，以排除腦幹中風。<br>（B）僅出現單向的水平眼震，可排除腦幹中風。<br>（C）若頭部推力測試（head impulse test）為正常，需高度懷疑腦幹中風。<br>（D）建議症狀緩解之後，繼續使用前庭抑制劑。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| A | 80. | 58 歲女性，有心血管病史，數月前因診斷胃潰瘍目前固定服用 Esomeprazole 中，本次因腹部絞痛，急性腹瀉來急診就診，下列敘述何者較不適當？<br>（A）Esomerprazole 會加強 cytochrome p450 的功能，增強部份藥物（如 Clopidogrel）的效果。<br>（B）長時間使用氫離子幫浦阻斷劑可能造成骨折、肺炎、慢性腎病、低血鎂等風險。<br>（C）需考慮 *Clostridium difficile* 造成腹瀉的可能性。<br>（D）停藥後有嚴重的胃酸逆流或是消化不良的症狀，可考慮使用 Famotidine。 |
| B | 81. | 65 歲男性，有糖尿病病史，因右小腿 8 公分撕裂傷至急診。病人表示 3 天前跌倒，傷口受泥土污染，至今未癒合，周圍皮膚呈紫紅色、滲出淡黃色液體，有壞死組織。身體診察顯示局部疼痛減退，但深部探查時劇烈疼痛，小腿肌肉僵硬。X 光檢查發現皮下氣體瀰漫。WBC 18,500 /μL，Platelet 210,000 /μL，CRP 35 mg/dL，Serum lactate 3.2 mmol/L，血糖 320 mg/dL。下列處置何者較適當？<br>（A）以高壓生理食鹽水沖洗，並會診感染科收治住院，使用抗生素 Piperacillin-Tazobactam + Clindamycin 治療。<br>（B）會診外科立即手術清創，進行廣泛性壞死組織切除及抗生素治療。<br>（C）以局部優碘消毒，並開立口服抗生素 Cephalexin，安排 48 小時後複診。<br>（D）緊急高壓氧治療，並使用廣效抗生素 Vancomycin + Meropenem。 |
| C | 82. | 68 歲患有心衰竭的女性，因急性肺水腫合併高血壓（血壓 190/110 mmHg）來院，主訴呼吸困難加劇，雙肺可聽見濕囉音，血氧飽和度 90%。下列藥物治療何者較適當？<br>（A）利尿劑（例如：Furosemide）為首選藥物，可快速改善肺水腫。<br>（B）硝普鈉（Sodium Nitroprusside）為一線治療，可迅速降低血壓並能同時降低前負荷與後負荷。<br>（C）硝酸甘油（Nitroglycerin）是合適的降壓藥，並可改善肺水腫。<br>（D）使用血管收縮劑（例如：Norepinephrine）可以穩定血壓，減少肺水腫惡化。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 83. | 62 歲男性，腹痛與便祕 3 天，腹痛為中下腹部間歇性絞痛，在進食後加劇。合併噁心，但無嘔吐或發燒。超音波及電腦斷層影像如下圖，下列何者為較適合的處置方式？<br>  <br>  <br>  <br>  <br>（A）置放鼻胃管減壓，禁食及靜脈輸液觀察。<br>（B）置放肛管減壓。<br>（C）聯絡外科醫師進行手術探查。<br>（D）給予 Neostigmine 嘗試放鬆腸段。 |
| C | 84. | 懷孕 30 週孕婦低速車禍就醫，無腹痛及明顯外傷。血壓 118/76 mmHg、心跳 82 次/min、$SpO_2$ 98%（room air）、呼吸 16 次/min。下列評估何者較適當？<br>（A）安排出院，並建議定期產檢追蹤。<br>（B）進行 Kleihauer-Betke 檢測，若結果陰性則可出院。<br>（C）進行連續胎心音監測至少 4~6 小時。<br>（D）立即進行腹部及骨盆腔電腦斷層掃描。 |
| D | 85. | 40 歲男性因臉部紅腫疼痛 2 天來急診。病灶呈現明顯邊界、局部有水泡（bullae）形成，病人體溫 39℃，白血球 14,000 /μL。下列何者較適當？<br>（A）較可能是蜂窩性組織炎。<br>（B）最常見的菌種是 *Bacteroides species*。<br>（C）可以口服 β-lactam drug plus metronidazole 治療。<br>（D）治療時應涵蓋 methicillin-resistant S. aureus。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 86. | 55 歲男性吃野菜後，嘔吐、流口水、心悸、痰多、焦躁不安、肌肉顫抖與癲癇發作，到達急診時意識不清，血壓 105/63 mmHg，心跳 58 次/min，呼吸 12 次/min，體溫 36.5℃，$SpO_2$ 92%。下列敘述何者較不適當？<br>（A）建立呼吸道後，給予洗胃與活性碳，減少毒素的吸收。<br>（B）給予靜脈注射鎮定劑 Benzodiazepines。<br>（C）若持續躁動或抽搐，可給予靜脈注射 Physostigmine。<br>（D）輸液或血液透析無法增加毒素的排出。 |
| C | 87. | 地震後常見的傷害與急診處置，下列敘述何者較適當？<br>（A）最常見的致死原因為頭部外傷引起的顱內出血。<br>（B）常引發當地區域腸胃道相關疾病。<br>（C）死亡個案多數發生在 3 小時內。<br>（D）因預警期足夠，受困與壓傷個案相對稀少。 |
| A | 88. | 82 歲女性，因跌倒後左側髖部疼痛。病人合併輕度失智症，無法清楚描述跌倒經過。身體診察發現病人指甲明顯過長，衣著不潔且伴有異味，右上臂內側及左大腿皆有瘀傷，臀部也發現多處的壓瘡。此病人的臨床處置，下列敘述何者較適當？<br>（A）高度懷疑老年虐待，應啟動通報機制並安排社工介入評估。<br>（B）主要與老年衰弱與自我忽略相關，應轉介老人醫學專科門診進一步評估。<br>（C）影像檢查未見明顯髖部骨折，建議返家休養，叮囑家屬加強居家照護。<br>（D）老年人皮膚脆弱易瘀青，加上失智症導致病史不可靠，若無直接目擊虐待的證據，無法啟動通報機制。 |
| D | 89. | 82 歲女性，夏季在無空調的房間內待了 1 天，長時間未飲水，家屬發現她坐在沙發上大量出汗且出現下肢痙攣（cramps）、暈眩、噁心及嘔吐等現象送至急診。到院時體溫 39.8℃，血壓 103/77 mmHg，心跳 112 次/min，呼吸 18 次/min，皮膚濕熱，GCS E4V5M6。下列敘述何者較適當？<br>（A）此類疾病常併發橫紋肌溶解（rhabdomyolysis）。<br>（B）治療以靜脈注射高張生理食鹽水為主，病情通常需住院觀察至少 48 小時。<br>（C）此類疾病常伴有低血鈉，輸液應優先選用 3% saline 與口服水份補充。<br>（D）若病情未持續惡化，通常不會出現神經學缺損症狀。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| A | 90. | 32 歲男性因服用乙醯胺酚（Acetaminophen）企圖自殺，於 6 小時後被送至急診。目前生命徵象穩定，AST 58 U/L、ALT 60 U/L，血清 Acetaminophen 濃度為 150 μg/mL。下列處置何者較適當？<br>（A）立即給予靜脈注射 N-acetylcysteine（NAC）。<br>（B）先抽血檢驗肝功能與凝血功能，待結果回報後再決定是否使用 NAC。<br>（C）若病人無症狀，可先觀察，不須立即給予 NAC。<br>（D）立即進行血液透析，以移除過量 Acetaminophen。 |
| B | 91. | 45 歲男性於登山時造成左膝外前側 5 公分撕裂傷，評估傷口未傷及肌腱韌帶。下列哪一項縫線與縫合方式較能達成穩定閉合與良好外觀？<br>（A）使用聚丙烯（polypropylene）縫線以 simple interrupted suture 完成表層縫合。<br>（B）深層以 vicryl 縫線做 deep dermal suture，表層以 nylon 縫線做 interrupted percutaneous suture 完成對合。<br>（C）可使用組織膠（tissue adhesive）封閉傷口，減少膝部移動再外加壓迫性敷料。<br>（D）使用 polydioxanone（PDS）縫線，採取 horizontal mattress technique 完成表皮閉合，避免進行深層縫合。 |
| C | 92. | 75 歲女性左側遠端橈骨骨折，骨科醫師建議保守治療。下列何種固定方式較適當？<br>（A）前臂副木（forearm-arm splint）。<br>（B）短臂副木（short-arm gutter splint）。<br>（C）糖鉗副木（sugar-tong splint）。<br>（D）豎腕副木（cock-up wrist splint）。 |
| B | 93. | 35 歲男性左側股骨中段骨折，合併膝關節脫臼，下列敘述何者較適當？<br>（A）長骨骨折可能導致神經牽扯或壓迫，易造成股神經損傷。<br>（B）數小時內出現呼吸喘、意識變化，脂肪栓塞可能性較低，應先尋找其他原因。<br>（C）股骨骨折出血可達 500~1,000 mL，故較小腿骨折更常造成腔室症候群。<br>（D）儘快進行膝關節復位，復位後確認遠端脈搏，正常則可以排除血管損傷。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| B | 94. | 10 歲男童，確診鐮狀細胞貧血，因劇烈頭痛、右側無力及言語不清至急診。腦部 MRI 顯示左側大腦中動脈梗塞。下列處置何者較適當？<br>（A）立即給予阿斯匹靈並觀察。<br>（B）施行全血置換輸血（exchange transfusion）。<br>（C）施行靜脈血栓溶解治療（tPA）。<br>（D）給予高劑量皮質類固醇治療腦部水腫。 |
| C | 95. | 58 歲男性，10 天前曾接受冠狀動脈介入治療並置放藥物塗層支架以治療左前降支狹窄。今早因劇烈胸痛，合併噁心與冒冷汗就診。生命徵象：血壓 70/50 mmHg、心跳 102 次/min、$SpO_2$ 98%。心電圖顯示 V2-V4 ST 段升高，troponin 顯著升高。病人表示近日因胃痛自行停用 Clopidogrel，下列處置何者較適當？<br>（A）立即施行床邊經胸心臟超音波以排除心肌破裂。<br>（B）以 Morphine、氧氣、硝酸甘油及 Heparin 保守處理。<br>（C）緊急聯絡心導管室進行再次冠狀動脈介入治療。<br>（D）給予 thrombolytic therapy 作為主要再灌流策略。 |
| C | 96. | 2 歲女童，因嚴重嘔吐與腹瀉來到急診，病程持續 3 天，家屬表示小孩明顯精神不佳、嗜睡，近 12 小時未進食，尿量減少。身體診察發現：皮膚乾燥，眼眶凹陷，心跳 160 次/min，血壓 78/45 mmHg，呼吸 34 次/min，四肢冰冷，毛細血管回填時間 4 秒。實驗室數據顯示：$Na^+$ 165 mEq/L，$K^+$ 3.0 mEq/L，$Cl^-$ 135 mEq/L，$HCO_3^-$ 12 mEq/L，BUN 35 mg/dL，Cr 1.2 mg/dL，血糖 80 mg/dL，滲透壓 315 mOsm/kg。下列處置何者較適當？<br>（A）立即快速靜脈輸注 5% Dextrose 以快速補充體液及休克狀況並儘速改善高血鈉。<br>（B）立即以每公斤體重至少 60 mL 的 0.9%生理食鹽水靜脈輸注快速補充體液。<br>（C）立即以每公斤體重 20 mL 的 0.9%生理食鹽水靜脈輸注，隨後改用 5% Dextrose in 0.9%生理食鹽水。<br>（D）立即靜脈輸注 3%高張食鹽水（hypertonic saline）以矯正高滲透壓狀態。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 97. | 2 歲男童因發燒、咳嗽 2 天至急診求診，經身體診察發現病童哭鬧不安，聽診雙肺有細小囉音（fine crackles），生命徵象：體溫 38.5℃，心跳 145 次/min，呼吸 42 次/min，血壓 80/50 mmHg，體重 12 公斤。醫師進行評估時發現病童對陌生環境顯得緊張，並不願意讓醫護人員接觸檢查。根據兒童生理與發展特徵，下列敘述何者較適當？<br>（A）病童呼吸速率符合該年齡層正常範圍，暫無需進一步評估呼吸窘迫徵象。<br>（B）該年齡層兒童已能與醫療人員溝通，因此通常能配合檢查。<br>（C）考量該年齡正常生理與發展特性，目前生命徵象屬可接受變異，建議先安撫病童並由母親協助配合完成基本檢查。<br>（D）病童行為反應異常，應懷疑有神經系統感染或代謝問題，應安排腦部影像檢查。 |
| B | 98. | 您正在急診室評估一名 35 歲言語混亂與行為異常之男性。根據急診訪談技巧（interview techniques in the ED），下列哪項訪談策略較不適當？<br>（A）先確保自己站在靠近出口的位置，與病人保持適當距離，再開始訪談。<br>（B）首先使用是非形式（Yes or No）或選擇型問句開頭，幫助患者表達想法。<br>（C）直視病人，適時使用肢體語言，以降低對方的敵意。<br>（D）詢問病情時，先重複病人使用的詞彙，再進一步請他們說明，以讓病人感受到被傾聽。 |
| C | 99. | 2 歲男童因發燒、食慾差與眼皮浮腫來到急診。父母提到病童約 1 週前有喉嚨痛病史，近 2 天小便顏色變深如可樂。身體診察顯示輕微高血壓，無明顯紅疹或關節腫脹；懷疑為腎絲球腎炎（glomerulonephritis）。下列哪項檢查結果較能支持此診斷？<br>（A）尿液中發現 WBC >10 /HPF，細菌培養陽性。<br>（B）尿液分析出現蛋白尿，尿比重>1.030，無紅血球或圓柱體（casts）。<br>（C）尿液鏡檢顯示紅血球圓柱體（RBC casts）。<br>（D）尿液比重低於 1.005，無蛋白尿或紅血球。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| D | 100. | 65 歲女性，有高血壓，因新發作的間歇性胸部不適就醫，過去 24 小時內已發作數次，初步 12 導程心電圖未顯示急性 ST 段或 T 波變化。下列處置何者較適當？<br>（A）服用舌下硝化甘油錠，若不能緩解疼痛，則可排除急性冠狀動脈症候群。<br>（B）High sensitivity cardiac troponin 在正常範圍內，可以讓病人出院。<br>（C）同時檢驗肌酸激酶心肌型同功酶（CK-MB）較為準確。<br>（D）若無禁忌症，應給予 300 mg Aspirin。 |
| B | 101. | 67 歲男性因虛弱與噁心 3 日來急診，近日有多次嘔吐與腹瀉，口乾、低血壓 88/56 mmHg、心跳 110 次/min、尿量明顯減少。抽血顯示：BUN 70 mg/dL、Cr 2.8 mg/dL、K 5.1 mEq/L、$HCO_3^-$ 18 mmol/L，尿液檢查顯示 Na 10 mEq/L、無蛋白尿或紅白血球。下列哪一項治療策略較合適用於此病人目前的急性腎損傷處置？<br>（A）儘速給予高劑量利尿劑（例如：Furosemide）促進尿量恢復。<br>（B）給予靜脈生理食鹽水以恢復循環體積。<br>（C）預防性投與腎毒性抗生素，例如：Aminoglycoside 以預防感染併發症。<br>（D）緊急透析以快速降低氮血症（azotemia）。 |
| B | 102. | 在戰場環境下，嚴重低血容性休克病人的初始液體復甦策略，需平衡組織灌流與防止凝血因子稀釋。根據美國戰術戰傷救護（TCCC）最新指引，以下何者為最理想的初始液體選擇？<br>（A）Lactated Ringer’s solution。<br>（B）Fresh whole blood。<br>（C）Colloid solution。<br>（D）Normal saline。 |
| D | 103. | 關於腸脂垂炎（epiploic appendagitis），下列敘述何者較適當？<br>（A）常伴隨有噁心嘔吐的症狀。<br>（B）可使用抗生素治療。<br>（C）超音波影像，呈現豐富血流病灶。<br>（D）電腦斷層影像，呈現卵形脂肪瘤（oval fatty mass）。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| D | 104. | 6 個月大的男嬰，持續高燒 3 天後燒退，但隨後發現皮膚出現紅色丘疹，主要分布於軀幹和四肢，無水泡。其他體徵包括食慾減退和嗜睡。血液檢查顯示白血球計數正常。下列何者為較可能的診斷？<br>（A）麻疹（Measles）。<br>（B）德國麻疹（Rubella）。<br>（C）水痘（Varicella）。<br>（D）玫瑰疹（Roseola）。 |
| C | 105. | 42 歲男性因陰莖腫脹疼痛至急診就醫。病人表示 6 小時前性行為後陰莖勃起未消退，持續僵硬且逐漸出現疼痛感。身體診察發現陰莖海綿體明顯充血堅硬，未見瘀傷或外傷跡象。下列處置何者較適當？<br>（A）立即手術探查以排除陰莖骨折。<br>（B）靜脈注射 Diazepam 放鬆陰莖平滑肌。<br>（C）陰莖海綿體穿刺放血。<br>（D）給予冰敷及陰莖向上固定觀察 24 小時。 |
| C | 106. | 35 歲女性，確診為人類免疫缺陷病毒（Human Immunodeficiency Virus, HIV）感染，病人目前規律服用抗病毒藥物且病毒量已受控制，病人日前之 HIV 病毒量<50 copies/mL 且 CD4 細胞計數維持正常範圍並計畫懷孕。下列描述何者較適當？<br>（A）孕婦可施打流感疫苗，但 HIV 感染之孕婦應避免接種流感疫苗。<br>（B）經過檢查後，發現此病人並無水痘（Varicella）抗體或是接種過水痘疫苗，因此病人要於懷孕時第一孕期內接種水痘疫苗，以確保胎兒安全。<br>（C）此病患若成功懷孕並順利產下新生兒，產下新生兒後 24 小時內要通報疾病管制署。<br>（D）HIV 抗病毒藥物可減少母嬰垂直感染風險，但懷孕期間應考慮減少抗病毒藥物的劑量，以降低藥物副作用對胎兒的影響。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| B | 107. | 關於連續皮下胰島素注射（continuous subcutaneous insulin infusion）病人的處置，何者較不適當？<br>（A）若需要施行核磁共振掃描而需要先移除連續皮下胰島素注射，可給予速效或長效型胰島素。<br>（B）若因手術需要禁食，建議暫時停用連續皮下胰島素注射，並每 30 到 60 分鐘測量血糖。<br>（C）在急診治療的依據還是以血液血糖值或指尖血糖值（serum or capillary glucose level）為主。<br>（D）若發生糖尿病酮酸血症，不建議在給予靜脈推注胰島素（bolus IV insulin）。 |
| D | 108. | 60 歲男性突發意識障礙，在地上張口呆視、咀嚼動作重複、持續 10 分鐘未語應，未見肢體抽搐，無跌倒或外傷。頭部電腦斷層未見異常，電解質正常。此病人較可能的診斷為何？<br>（A）Todd’s paralysis。<br>（B）Complex partial seizure。<br>（C）Psychogenic nonepileptic seizure。<br>（D）Nonconvulsive status epilepticus。 |
| C | 109. | 60 公斤的中年男性，無癲癇病史，因「持續抽搐超過 10 分鐘」送至急診，到院時仍全身型僵直-陣攣性癲癇（Generalized tonic-clonic seizure, GTC），無恢復意識。已緊急給予三次靜脈注射 Lorazepam 共 6 mg，但發作仍未終止。下列處置何者較適當？<br>（A）追加 Lorazepam 2 mg IV。<br>（B）立即插管並給予 Propofol 持續輸注。<br>（C）立即給予 Phenytoin 或 Levetiracetam。<br>（D）靜脈注射高張鹽水（3% NaCl），矯正可能的低血鈉。 |
| D | 110. | 35 歲男性電工在工作時，右手不慎接觸到一條裸露的金屬導線導致電擊，當時他左手握住一根接地的金屬管道。下列敘述何者較不適當？<br>（A）交流電可能產生肌肉強直（muscular tetany），使病人無法鬆開電源。<br>（B）交流電和直流電都可能將病人拋離電源，從而導致嚴重的鈍傷。<br>（C）該病人電流流經的路徑是手對手，會穿過胸部與心臟。<br>（D）低頻（50 至 60 Hz）直流電可能比交流電更危險，導致心室顫動（ventricular fibrillation）機會更高。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 111. | 2 歲男童在家中進食時突然劇烈咳嗽，並開始發出喘鳴聲（stridor），母親見狀立刻帶至急診。到院時，病童已喪失意識，血氧飽和度 90%。聽診顯示吸氣性喘鳴聲。下列處置何者較適當？<br>（A）立即進行氣管內插管（endotracheal intubation）。<br>（B）給予哈姆立克法急救（Heimlich maneuver）。<br>（C）使用喉頭鏡（laryngoscopy）及 McGill forceps 嘗試去移除呼吸道內的異物。<br>（D）持續壓胸給氧直到異物自行排出。 |
| D | 112. | 對於創傷後症候群（PTSD）的病人，如果恐慌發作（panic attack），但拒絕針劑藥物注射時。下列何種口服藥物給予較為適當？<br>（A）Duloxetine 20 mg。<br>（B）Escitalopram 20 mg。<br>（C）Fluoxetine 20 mg。<br>（D）Alprazolam 4 mg。 |
| D | 113. | 65 歲男性，4 天前搬家移動重物後嚴重下背痛，雙腳大腿後側疼痛並合併股間有刺痛感，且小便解不出來。生命徵象穩定，沒有發燒，身體診察發現背部腰椎位置有壓痛感，下肢深層肌腱反射減弱，股間與大腿後側感覺異常，且下腹部鼓脹、導尿導出 600 mL 的尿液。下列敘述何者較適當？<br>（A）本病症靠病史診斷不可靠，主要依靠影像學腰薦（lumbosacral）電腦斷層檢查確診。<br>（B）跟圓錐症候群（conus medullaris syndrome）相比，本病症的疼痛通常比較輕微。<br>（C）小便滯留通常很快就會發生，早期就會有滿溢性尿失禁（overflow urine incontinence）。<br>（D）大便失禁不見得會發生，施行肛門指診結果正常也不一定能排除此疾病。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| B | 114. | 60 歲男性，有規則服用 Metoprolol。食用海鮮後 10 分鐘，出現面部紅腫、呼吸困難、與低血壓。初步處置：腎上腺素 IM 0.3 mg 兩劑，生理食鹽水 1,500 mL，Diphenhydramine + Methylprednisolone 靜脈注射。處置後之 $SpO_2$ 91%，血壓 76/48 mmHg，心跳 48 次/min ，呼吸 28 次/min，病人持續喘鳴，意識逐漸模糊，預備插管與氣道保護。下列何者為此時較適當的下一步處置？<br>（A）改用 Vasopressin 靜脈滴注。<br>（B）每 5 分鐘靜脈注射 Glucagon 1 mg。<br>（C）給予 Hydrocortisone 1,000 mg IV。<br>（D）給予 Atropine 1 mg IV。 |
| D | 115. | 關於 VT（ventricular tachycardia）以及 SVT（supraventricular tachycardia）的區分，下列敘述何者較適當？<br>（A）如果 P 波與 QRS 無關，支持 SVT。<br>（B）如果 rhythm 極度不規則，優先考慮 VT。<br>（C）若 R 到 S 的距離超過 100 ms，支持 SVT。<br>（D）若胸前導程（precordial leads）QRS 皆為負向，優先考慮 VT。 |
| D | 116. | 2 歲男童因嚴重呼吸窘迫送至急診，在進行插管時，下列處置何者較適當？<br>（A）直接選擇 7.0 mm 內徑（internal diameter, ID）的氣管內管（ETT），並進行快速序列插管（RSI）。<br>（B）由於解剖特性，2 歲以下兒童應避免使用直型喉鏡片（Miller blade），應優先使用彎型喉鏡片（Macintosh blade）。<br>（C）插管前應使用 laryngoscope 觀察會厭（epiglottis），考慮使用無氣囊氣管內管（uncuffed ETT）以減少氣道阻力。<br>（D） 可考慮環狀軟骨壓迫術（cricoid pressure），但有可能因此技術導致呼吸道阻塞。 |
| D | 117. | 55 歲男性，右肩疼痛已持續 3 個月，最近惡化。他表示舉手及高舉活動困難。身體診察發現肩外展與外旋無力，並且 drop arm test 為陽性。較可能的診斷為何？<br>（A）肩峰下滑囊炎（subacromial bursitis）。<br>（B）肱二頭肌肌腱病變（biceps tendinopathy）。<br>（C）沾黏性關節囊炎（adhesive capsulitis）。<br>（D）旋轉肌腱撕裂（rotator cuff tear）。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 118. | 35 歲男性因右腳凍傷（frostbite）已完成初步復溫（rewarming）治療，使用 37℃至 39℃的水浸泡後，受影響部位已呈現紅斑且柔軟。然而，復溫後 2 小時，注意到右腳的遠端脈搏變得微弱。下一步應採取何種臨床處置？<br>（A）立即對凍傷的組織進行外科清創。<br>（B）給予 Aspirin 325 mg 口服以改善血流。<br>（C）評估當地凍傷治療專業能力並考慮轉診至有凍傷專業機構。<br>（D）繼續局部蘆薈霜（topical aloe vera cream）塗抹並觀察脈搏變化。 |
| B | 119. | 懷孕 28 週孕婦確診妊娠糖尿病，糖化血色素 5.9%，無其他合併症。下列處置何者較適當？<br>（A）立即開始長效胰島素 Glargine（Lantus®），以穩定血糖。<br>（B）先行飲食控制與運動管理，若血糖未達標再考慮胰島素 Detemir（Levemir®）。<br>（C）口服降血糖藥物 Metformin、Glyburide 均為 FDA 正式核准用於妊娠糖尿病。<br>（D）在妊娠期間，NPH 胰島素較 Detemir（Levemir®）更安全且具明顯療效優勢。 |
| C | 120. | 下列關於神經性厭食症（anorexia nervosa）必須住院的適應症，何者較不適當？<br>（A）最近常常暈厥。<br>（B）有急性聽幻覺的出現。<br>（C）鉀離子小於 3.2 meq/L。<br>（D）夜間心跳小於 45 次/min。 |
| A | 121. | 34 歲男性，剛從東南亞旅遊返國 3 天，腹瀉伴有腹絞痛 2 日，無血便、無發燒。每日排便約 6~8 次，呈水樣，伴輕微脫水現象。體溫 37.4℃，血壓 110/70 mmHg，心跳 95 次/min。下列處置何者較不適當？<br>（A）可經驗性給予 Ciprofloxacin 500 mg BID 三日。<br>（B）可短期使用 Loperamide 緩解症狀。<br>（C）由於腹瀉頻繁，此病人以經口補充水份及電解質為主。<br>（D）若無法容忍飲食，可禁食 12~24 小時以減少腸道分泌與排便頻率。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 122. | 59 歲男性於田裡工作時，足底不慎被生鏽的鐮刀割傷，7 天後出現牙關緊閉、吞嚥困難、全身肌肉僵硬痙攣等症狀。下列處置何者較適當？<br>（A）病情嚴重時，經常合併意識不清與呼吸衰竭，緊急時須插管使用呼吸器，並輔以鎮定劑與肌肉鬆弛劑治療。<br>（B）安排傷口清創手術，並於清創後注射破傷風免疫球蛋白（tetanus immunoglobulin）與抗生素（Metronidazole）。<br>（C）破傷風免疫球蛋白（tetanus immunoglobulin）建議治療劑量為單次肌肉注射 3,000~6,000 units。<br>（D）病人於發病時注射第 1 劑破傷風類毒素（tetanus toxoid），痊癒後能獲得短暫免疫，但 5 年後須再追加第 2 劑類毒素，以維持免疫力。 |
| C | 123. | 67 歲男性因意識改變被送至急診，腦部電腦斷層顯示有自發性腦出血（intracerebral hemorrhage），病史顯示病人長期服用 Warfarin 治療心房顫動（atrial fibrillation）。關於此病人凝血異常逆轉的處理，下列敘述何者較適當？<br>（A）給予維生素 K（Vitamin K）5-10 mg IV，可立即逆轉 Warfarin 的抗凝效果。<br>（B）給予基因重組活化凝血第七因子（recombinant factor VIIa）40~120 μg/kg IV Q2H， 可改善腦出血後的存活率。<br>（C）給予凝血酶複合濃縮物（prothrombin complex concentrates）50 IU/kg IV，作用起效時間快，造成血栓栓塞的風險與劑量相關。<br>（D）可使用 O-血型的新鮮冷凍血漿（fresh frozen plasma）無需進行血型配對，15 mL/kg 的劑量可能需要大量輸注，許多病人無法耐受。 |
| B | 124. | 26 歲女性陰道分泌物有異味 3 天就診，無解尿疼痛或發燒。陰道分泌物檢查 Whiff test 呈陽性，pH 值為 5.0。下列診斷何者較適當？<br>（A）念珠菌性陰道炎（Candidiasis）。<br>（B）細菌性陰道炎（Bacterial Vaginosis）。<br>（C）陰道滴蟲感染（Trichomoniasis）。<br>（D）萎縮性陰道炎（Atrophic Vaginitis）。 |
| B | 125. | 對於 cardiac troponin 的描述，下列何者較適當？<br>（A）在腎功能不全的病人，較常見 troponin-I 上升。<br>（B）在透析之後，troponin-T 通常數值會上升，而 troponin-I 則會下降。<br>（C）主動脈剝離的病人合併 troponin 上升，預後無明顯差異。<br>（D）目前 hs-troponin 在胸痛出現後的 1 小時即有 92~94%的敏感度。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 126. | 28 歲男性機車車禍被送至急診，呼吸 30 次/min，心跳 120 次/min，血壓 100/65 mmHg，$SpO_2$ 91%（氧氣面罩 10 L/min）。左側胸部呼吸音減弱，頸部觸診有皮下氣腫。心臟聽診出現 Hamman's sign。下列最可能的診斷為何？<br>（A）張力性氣胸。<br>（B）大量血胸。<br>（C）縱膈腔氣腫。<br>（D）肺挫傷。 |
| D | 127. | 關於跨性別女性之賀爾蒙治療，下列敘述何者較不適當？<br>（A）常合併使用 Spironolactone，因為此藥物可抑制睪固酮分泌及抑制雄性激素與受體結合。<br>（B）雌激素治療會增加高血壓、膽結石及高三酸甘油脂發生率。<br>（C）雌激素治療不會影響聲帶及骨骼，但會造成性慾降低及睪丸縮小。<br>（D）若病人出現頭痛及外側視野缺損，須優先考慮腦靜脈竇栓塞。 |
| B | 128. | 40 歲女性，近期曾自行用尖銳物清理指甲邊緣，之後開始出現右側拇指紅腫及疼痛，身體診察發現右側拇趾內側甲溝處腫脹，有顆粒狀組織增生，局部輕微滲出物。下列處理方式何者較適當？<br>（A）口服抗生素並建議病人回家熱敷，待症狀改善後再決定是否進一步處置。<br>（B）立即進行指甲部分切除術，必要時考慮化學燒灼術。<br>（C）局部熱敷及外用抗生素藥膏，避免進一步刺激該部位。<br>（D）局部消炎藥治療，如止痛凝膠或類固醇藥膏。 |
| B | 129. | 38 歲女性，BMI 為 40 $kg/m^2$至急診，下列哪種藥物的劑量應基於「理想體重」（ideal body weight）而非「實際體重」（total body weight）計算？<br>（A）Vancomycin。<br>（B）Cephalosporins。<br>（C）Succinylcholine。<br>（D）Enoxaparin。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 130. | 59 歲女性服用多顆帕金森氏症的藥物 Selegiline HCl（Parkryl®）。坐立難安、手抖、頭痛、視力模糊，血壓 240/126 mmHg，心跳 105 次/min，體溫 38.9℃，意識清楚，EKG 為竇性心搏過速。首選降血壓藥物為何？<br>（A）Labetalol 靜脈注射。<br>（B）Nicardipine 靜脈滴注。<br>（C）Nitroprusside 靜脈滴注。<br>（D）Benzodiazepines 靜脈注射。 |
| C | 131. | 25 歲男性被炸彈攻擊後步行入院，軀幹與四肢多處金屬碎片穿刺傷。血壓 122/76 mmHg，心跳 108 次/min，呼吸 24 次/min，$SpO_2$ 95%（room air），初步檢查無明顯氣胸或內出血。下列處置何者較適當？<br>（A）需安排頭部及胸腹部電腦斷層以排除潛在內臟損傷。<br>（B）若目前無需手術處理，可立即進行急診傷口縫合。<br>（C）觀察 4~6 小時再評估是否可出院。<br>（D）應預防性給予 Ampicillin/Sulbactam 或 Clindamycin 以控制感染。 |
| D | 132. | 1 歲半男童因左眼出現淡黃色分泌物 2 天，被帶至急診就醫評估，下列敘述及處置何者較適當？<br>  <br>（A）疑鼻淚管狹窄（dacryostenosis），可以考慮給予預防性抗生素。<br>（B）鼻淚管處瘀腫（bluish-hued mass），疑淚囊突出（dacryocele）多半自限性。<br>（C）疑急性淚腺炎（acute dacryoadenitis），常為細菌感染，宜抗生素眼藥水治療 1~2 週。<br>（D）疑急性淚囊炎（acute dacryocystitis），因可能導致蜂窩性組織炎，需住院抗生素治療。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 133. | 40 歲男性因頭暈及血壓低就診，超音波及進行進階血流動力學監測，結果發現下腔靜脈鼓脹、系統性血管阻力（SVR）增加，造成該病人休克的原因何者較適當？<br>（A）神經性休克。<br>（B）腸胃道出血。<br>（C）急性心肌梗塞。<br>（D）心包膜填塞。 |
| C | 134. | 30 歲初產婦，剖腹產術後第 4 天發燒、下腹悶痛，無惡臭陰道分泌物或傷口感染。給予廣效抗生素 48 小時後，仍持續發燒。電腦斷層顯示右側卵巢靜脈內有灌流缺損（perfusion defect），下列敘述何者較適當？<br>（A）不需要再繼續使用抗生素，應改以抗凝血治療。<br>（B）電腦斷層和核磁共振是標準檢查，可以用來排除此疾病。<br>（C）開始使用低分子量肝素（Low Molecular Weight Heparin）。<br>（D）日後需要抗血小板藥物長期治療以防復發。 |
| C | 135. | 55 歲男性，有糖尿病與長期使用 Ibuprofen，今晨突發大量黑便。鼻胃管抽吸呈現咖啡色內容物。生命徵象：血壓 90/60 mmHg，心跳 110 次/min，Hb 8.5 g/dL。針對此病人的治療，下列何者較適當？<br>（A）若病人對輸液反應不佳，持續出血且出現休克徵候，需盡快使用升壓藥。<br>（B）給予輸注紅血球濃厚液，使 Hb 恢復至 9~10 g/dL 以上。<br>（C）給予靜脈輸注氫離子幫浦抑制劑。<br>（D）合併靜脈輸注 Octreotide 可降低出血與死亡風險。 |
| B | 136. | 52 歲男性有糖尿病史，登山至海拔 3,500 公尺高原旅遊，當晚出現頭痛、無力、意識混亂。下列診斷及處置何者較適當？<br>（A）急性高山病（Acute Mountain Sickness, AMS），必要時使用 Acetazolamide。<br>（B）高海拔腦水腫（High-Altitude Cerebral Edema, HACE），需用 Dexamethasone。<br>（C）高海拔肺水腫（High-Altitude Pulmonary Edema, HAPE），需立即給予氧氣。<br>（D）高海拔低血糖（High-Altitude HypoGlycemia, HAHG），需用 Glucagon 及 Dexamethasone，並盡快安排下撤。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| B | 137. | 14 歲女性，過去 3 年來反覆發作的嚴重噁心與嘔吐，每次持續約 3-4 天，期間無法進食，需至急診接受靜脈輸液治療。發作前常伴有疲倦、畏光及盜汗，且發作期間無法緩解症狀。過去曾被診斷為偏頭痛，並有焦慮病史。今日來診時無發燒，生命徵象穩定，身體診察無腹膜炎現象。下列藥物何者為較適當的預防發作藥物？<br>（A）Ondansetron。<br>（B）Amitriptyline。<br>（C）Lorazepam。<br>（D）Risperidone。 |
| B | 138. | 關於血管通路，下列敘述何者較適當？<br>（A）靜脈切開法（venous cutdown）的首選位置是頭靜脈（cephalic vein）。<br>（B）進行股靜脈（femoral vein）中心靜脈導管置放時，若在腹股溝韌帶（inguinal ligament）之上置入針頭，可能造成血管損傷，並造成後腹腔出血（retroperitoneal hemorrhage）。<br>（C）進行橈動脈（radial artery）動脈導管置放前，進行 Allen test，可以預測缺血併發症的機率。<br>（D）進行鎖骨下靜脈（subclavian vein）中心靜脈導管置放，使用鎖骨上進針法（supraclavicular approach）的體表入針位置為胸鎖乳突肌胸骨頭（sternal head of the sternocleidomastoid muscle）外側 1 公分，且位於鎖骨後方 1 公分處。 |
| A | 139. | 下列哪一個心包穿刺術（pericardiocentesis）穿刺部位較不容易引起氣胸？<br>（A）劍突下（subxiphoid）。<br>（B）胸骨旁（parasternal）。<br>（C）心尖（apical）。<br>（D）鎖骨間（interclavicular）。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 140. | 6 個月大嬰兒 懷疑消化道出血帶至急診，父母表示在更換尿布時發現大量暗紅色血液，過去 24 小時內嬰兒已排出 3 次血便，無發燒、嘔吐或腹瀉。嬰兒食慾良好，活力正常，母乳餵養，無換奶或進食配方奶粉的病史。身體診察：生命徵象穩定（心跳 130 次/min，血壓正常，肢體末梢灌流良好）、腹部柔軟無壓痛，無腸鳴音減少，肛門檢查未見裂傷或明顯血跡、 糞便潛血檢測陽性，未見黏液或膿液。下列何者較可能是該嬰兒腸道出血的原因？<br>（A）感染性腸胃炎（infectious gastroenteritis）。<br>（B）腸套疊（intussusception）。<br>（C）梅克爾憩室（Meckel's diverticulum）。<br>（D）潰瘍性結腸炎（ulcerative colitis）。 |
| B | 141. | 關於中度低體溫（II 期），核心體溫 28~32℃，治療的注意事項，何者較不適當？<br>（A）初期不建議使用升壓劑，因為低溫本身已經誘發最大血管收縮。<br>（B）心房顫動、心房撲動、心搏過緩常見，需積極處理。<br>（C）若復溫後出現血管擴張性低血壓，可考慮使用升壓劑。<br>（D）靜脈輸液本身不會提供太多熱量，但能防止低溫加重。 |
| D | 142. | 62 歲男性，因高血壓近期服用 Lisinopril。早上發現嘴唇與舌頭快速腫脹，伴隨吞嚥困難與說話不清。過去無類似病史，無食物過敏史，也無家族性水腫史。初步處置已停止使用 Lisinopril，並給予 IV 體液與氣道監測。以下哪一種治療選擇較有可能對此病人有效？<br>（A）Epinephrine 0.5 mg IM。<br>（B）Diphenhydramine + Methylprednisolone。<br>（C）Ecallantide 30 mg SC。<br>（D）Icatibant（Firazyr®）30 mg SC。 |
| B | 143. | 65 歲男性，有第二型糖尿病病史，因右側耳痛、化膿性耳漏及聽力下降持續 2 週來急診就醫。他表示夜間疼痛明顯加劇，並且過去 3 天內出現右側臉部無力，嘴角下垂，無法完全閉合右眼。身體診察發現右側外耳道紅腫，並有肉芽組織形成。患側外耳道壓痛明顯，伴隨耳後壓痛，右側額部肌肉無法皺眉，閉眼不完全。下列處置何者較適當？<br>（A）口服 Ciprofloxacin 並安排門診耳鼻喉科追蹤。<br>（B）住院給予靜脈注射 Ciprofloxacin，緊急耳鼻喉科會診。<br>（C）住院給予靜脈注射 Ceftriaxone，並安排 CT 顳骨評估顱底骨侵襲。<br>（D）立即進行手術引流（乳突切除術）。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| D | 144. | 關於社區性肺炎，下列何者較不適當？<br>（A）感染 *Legionella pneumonia* 的病人常出現腸胃道症狀，包括腹痛、嘔吐、腹瀉。<br>（B）孕婦感染流感病毒較容易出現肺炎重症，當孕婦出現流感症狀時，建議給予抗病毒藥物。<br>（C）入住普通病房的社區性肺炎病人，使用 Cephalosporin 治療外，還可以加入 Macrolide 類藥物。<br>（D）感染 *Mycoplasma pneumonia* 的病人有時會出現紅疹、關節痛、腸胃道症狀。 |
| D | 145. | 75 歲男性，有 COPD（chronic obstructive pulmonary disease）、高血壓、冠狀動脈疾病病史合併心房顫動，因外傷左肩關節脫臼就醫。血壓 189/110 mmHg，心跳 128 次/min。疼痛指數 pain score 8。欲實施程序性鎮靜與止痛 procedural sedation anesthesia（PSA）後復位。關於藥物的選擇，下列敘述何者較不適當？<br>（A）Etomidate 具有較少的心血管抑制，適合短時間的復位程序。<br>（B）Midazolam 不適合單獨使用，對於復位術來說，鎮靜時間太長，又沒有止痛效果。<br>（C）如果確認沒有其他外傷性出血，可使用 Propofol 劑量 0.25-0.5 mg/kg。<br>（D）首選藥物為 Ketamine，因其較不會抑制呼吸驅力，且具有止痛效果。 |
| C | 146. | 關於橫紋肌溶解症，下列敘述何者較不適當？<br>（A）成人最常見的原因為藥物或酒精濫用，兒童最常見的原因為病毒感染。<br>（B）常出現電解質異常，如高血鉀、高血磷、低血鈣，橫紋肌溶解早期出現的低血鈣通常不需要特別治療。<br>（C）給予晶體（crystalloid）溶液輸液目標應達到排尿量 1mL/kg/hr。<br>（D）止痛應避免使用 NSAIDs 類的藥物。 |
| A | 147. | 35 歲男性，陣發性咳嗽（paroxysmal cough）超過 2 週，多在夜間發作，並會造成咳嗽後嘔吐（post-tussive emesis）。懷疑可能感染百日咳，下列處置何者較適當？<br>（A）立即給予 Azithromycin 治療。<br>（B）成人症狀通常自限，建議給予止咳藥物減輕症狀。<br>（C）接種 DTaP 疫苗，預防即可。<br>（D）等待 PCR 結果後再決定是否給予抗生素。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| B | 148. | 35 歲男性，全身性皮膚紅疹與疼痛，檢查發現廣泛性紅斑，並伴隨水泡及表皮剝離，軀幹與四肢超過 30%體表面積，輕微摩擦即造成表皮脫落。病人最近服用新處方抗生素，並出現口腔及眼結膜潰瘍。較可能的診斷為何？<br>（A）史帝文生氏症候群（Stevens-Johnson syndrome）。<br>（B）壞死性毒性表皮溶解症（toxic epidermal necrolysis）。<br>（C）脫屑性紅皮症（exfoliative erythroderma）。<br>（D）壞死性筋膜炎（necrotizing fasciitis）。 |
| D | 149. | 50 歲女性，無藥物史及疾病史。這次因突發性劇烈頭痛及嘔吐被帶到急診室。意識清楚，腦部電腦斷層掃描顯示蜘蛛膜下腔出血（subarachnoid hemorrhage）。下列處置何者較適當？<br>（A）應立即進行手術血腫清除術，以降低顱內壓。<br>（B）靜脈注射維生素 K 和新鮮冷凍血漿（fresh frozen plasma），以校正凝血功能。<br>（C）建議使用 Nitroprusside 控制血壓，以降低再出血風險。<br>（D）建議於發病 96 小時內開始使用 Nimodipine，以降低血管痙攣發生率。 |
| A | 150. | 72 歲男性，具有高血壓和吸菸病史，因突發性嚴重腹部及背部疼痛至急診。出現盜汗、血壓 88/60 mmHg、心跳 122 次/min。身體診察發現中腹部可觸及搏動性腫塊。下列處置何者較適當？<br>（A）立即進行床邊超音波。<br>（B）安排施打顯影劑的電腦斷層。<br>（C）靜脈注射 Labetalol 以降低血壓。<br>（D）進行腹部 X 光檢查以評估動脈瘤鈣化情形。 |
| D | 151. | 關於流感的治療與預防性抗病毒藥物使用，下列敘述何者較適當？<br>（A）18 歲健康成人感染流感後 72 小時併發細菌性肺炎，插管住院，則已無需用抗病毒治療。<br>（B）30 歲懷孕 28 週的婦女確診流感，應盡量避免使用抗病毒藥物，以免影響胎兒的發育。<br>（C）36 歲健康成人出現流感症狀後 60 小時就醫，仍應建議使用 Oseltamivir 以減少重症率。<br>（D）72 歲慢性腎病患者 1 天前密切接觸過確診流感的孫子，應開立預防性 Oseltamivir。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| D | 152. | 18 個月大男童，父母目擊誤食鈕扣電池，下列各種不同情境與相應處置，何者較適當？<br>（A）到達急診立即安排非顯影劑電腦斷層掃描來確認鈕扣電池的位置。<br>（B）若食入超過 4 小時，鈕扣電池仍在食道，可考慮進行 Foley 導尿管移除法。<br>（C）若鈕扣電池合併磁鐵共同食入，應立即會診外科安排緊急手術。<br>（D）若鈕扣電池的位置在胃中，無不適且無共同食入磁鐵，可安排門診追蹤。 |
| B | 153. | 72 歲男性，因突發性腹痛至急診就醫，被診斷為破裂性腹主動脈瘤（abdominal aortic aneurysm）。其血壓 88/60 mmHg，心跳 122 次/min。已建立兩條大口徑靜脈輸液管路。下一步復甦措施何者較適當？<br>（A）靜脈輸注 2 公升生理食鹽水進行積極性液體復甦。<br>（B）維持收縮壓在 80~90 mmHg，避免過度升壓以減少出血。<br>（C）靜脈注射 Norepinephrine 以提升血壓至 120 mmHg。<br>（D）僅在血紅素下降至 7 g/dL 以下時輸注 1 單位濃縮紅血球。 |
| B | 154. | 54 歲男性具有嚴重慢性阻塞性肺病，因無法脫離呼吸器，於 4 天前接受氣管造口術（tracheostomy）。在急診室內，氣管造口導管意外脫落，病人立即出現嚴重呼吸窘迫，目前生命徵象如下：血壓 130/84 mmHg、心跳 125 次/min、呼吸 40 次/min、血氧飽和度 89%（使用非再呼吸面罩 non-rebreathing mask）。身體診察發現，氣管造口（Stoma）外觀部分閉合且伴隨出血。病人極度躁動不安。下一步應立即採取的處置何者為宜？<br>（A）盲目嘗試重新盲插氣管造口導管。<br>（B）使用袋瓣罩甦醒球（bag-valve-mask, BVM）進行人工輔助通氣，同時準備進行經口氣管插管。<br>（C）使用纖維支氣管鏡（fiberoptic bronchoscope）引導重新插入氣管造口導管。<br>（D）立即執行經皮氣管造口術（percutaneous tracheostomy）以建立新氣道。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| B | 155. | 65 歲男性，主訴突然左側肢體無力及言語不清從症狀開始到急診掛號約 4 小時，既往有高血壓、糖尿病病史。到院時 NIHSS 15 分，腦部 CT 做完無出血，此時為有症狀後 4.5 小時，CTA（電腦斷層血管攝影）顯示右側中大腦動脈（MCA）近端完全阻塞（M1）。根據目前的治療指引，下列處置何者較適當？<br>（A）立即給予 rtPA（靜脈血栓溶解）並觀察 24 小時。<br>（B）立即進行血管內機械性血栓取出術（Endovascular Thrombectomy, EVT）。<br>（C）先使用 Aspirin 200 mg 口服，打上生理食鹽水，辦理神經內科住院。<br>（D）由於發病時間已超過 3 小時，不建議進行任何血栓移除治療。 |
| C | 156. | 78 歲男性，輕度腹脹、噁心與食慾不佳，無腹部手術史。身體診察顯示輕微右下腹壓痛，無反彈痛或肌肉僵直，體溫 36.8℃。血液白血球 12,000 /μL。電腦斷層顯示急性闌尾炎，下列敘述何者較不適當？<br>（A）此病人 Alvarado Score 至少 6 分。<br>（B）保持禁食並給予適度輸液與止痛。<br>（C）考量高齡手術風險，建議非手術治療較好。<br>（D）抗生素選擇 Metronidazole + Ciprofloxacin 靜脈注射。 |
| A | 157. | 65 歲男性因急性上腸繫膜動脈缺血（acute mesenteric ischemia）接受手術治療，術後因大量失血在加護病房接受輸血。輸血進行約 20 分鐘後，病人突然出現發燒，體溫 39℃、寒顫、血壓 90/55 mmHg、心跳 120 次/min、尿液顏色變深，並且抱怨腰背部劇烈疼痛。較可能的輸血反應為何？<br>（A）急性血管內溶血性輸血反應（Acute intravascular hemolytic reaction）。<br>（B）遲發性溶血性輸血反應（Delayed extravascular hemolytic reaction）。<br>（C）非溶血性發熱性輸血反應（Febrile nonhemolytic transfusion reaction）。<br>（D）過敏性輸血反應（Allergic transfusion reaction）。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 158. | 29 歲女性主訴下腹悶痛與陰道點狀出血。尿妊娠試驗陽性，陰道超音波未見子宮內妊娠但有一個 extra-ovarian adnexal mass。下列何者較適當？<br>（A）若血流動力學不穩定，藥物 Methotrexate 為優先的治療選擇。<br>（B）Methotrexate 給藥方式為靜脈注射，劑量為 5,000 mg/m² 。<br>（C）若 β-hCG >5,000 mIU/mL，可考慮 Methotrexate 多劑療法，以提高治療成功率。<br>（D）Methotrexate 治療後，黃疸為常見併發症，少數病人會有下腹疼痛。 |
| C | 159. | 29 歲女性懷孕 33 週，右側小腿突發嚴重腫痛就醫。無血栓病史，目前妊娠糖尿病接受飲食調控。Doppler 超音波確認右側下肢深靜脈栓塞，下列何者處置較適當？<br>（A）立即啟動口服 Warfarin 治療，預防肺栓塞。<br>（B）優先考慮進行血管介入導管溶栓術（catheter-directed thrombolysis）。<br>（C）立即給予低分子量肝素（Low-molecular-weight heparin）皮下注射治療。<br>（D）暫時觀察病情變化，症狀惡化時再啟動抗凝血治療。 |
| D | 160. | 有關流行性感冒的敘述，下列何者較適當？<br>（A）抗病毒藥物早期使用能縮短病程 0.5~1 天，並降低噁心、嘔吐的機率。<br>（B）抗病毒藥物應在症狀發作 48 小時內使用，若超過時間則無使用效益。<br>（C）若選用 Baloxavir 效果跟副作用跟 Oseltamivir 相當。<br>（D）Oseltamivir 於接觸流感病人後，預防性使用劑量為 75 mg QD 使用 7 天。 |
| D | 161. | 8 個月男嬰由家屬帶至急診，主訴近日出現食慾下降與活動力減退。家屬表示昨日晚間開始有發燒，今晨發現病童呻吟且拒絕喝奶。生命徵象：體溫 38.8℃、心跳 160 次/min、呼吸 38 次/min、血壓 85/55 mmHg，無發疹，前囟門略膨出。Brudzinski 與 Kernig sign 無法評估。下列處置何者較適當？<br>（A）安排腦部影像檢查以排除腦出血。<br>（B）等候血液與腦脊髓液檢驗報告，再決定是否使用抗生素。<br>（C）給予退燒藥並觀察臨床反應。<br>（D）抽血與腰椎穿刺送檢，並同時給予經驗性抗生素治療。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| B | 162. | 長期接受血液透析的 72 歲男性，近來出現手腕疼痛與握力下降，今手腕無法活動及疼痛來診，X 光發現骨囊腫（bone cyst）合併骨折。下列症狀原因何者較可能？<br>（A）Aluminum-induced osteomalacia。<br>（B）β2-microglobulin amyloidosis。<br>（C）Secondary hyperparathyroidism。<br>（D）Renal osteodystrophy from vitamin D3 deficiency。 |
| C | 163. | 62 歲男性，突然咳血約 300 mL 伴隨呼吸窘迫。血壓 105/70 mmHg，心跳 112 次/min，呼吸 28 次/min，血氧飽和度 88%，胸部 X 光顯示左下肺葉浸潤，關於此病人的氣道處理，下列敘述何者較適當？<br>（A）插管時應選擇較小口徑的氣管內管以減少對氣道的損傷。<br>（B）氣管插管後應將病人置於右側臥位置以確保氣體交換功能。<br>（C）常規插管失敗，可改為 cricothyrotomy 作為替代方案。<br>（D）將單腔氣管內管插入左主支氣管以控制出血。 |
| B | 164. | 50 歲男性，無過去病史，近 2 週排便時出現劇烈肛門疼痛，且有鮮紅色血便。近日發現肛門周圍有間歇性膿性分泌物流出。檢查發現肛周皮膚紅腫且觸痛，伴有波動感，體溫 38.5℃。下列處置何者較適當？<br>（A）開立口服抗生素並安排門診追蹤。<br>（B）立即進行切開引流。<br>（C）使用硝酸甘油軟膏以緩解疼痛。<br>（D）立即進行橡皮圈結紮術。 |
| C | 165. | 年輕男性有服用抗憂鬱劑，意識改變、躁動不安、肌陣攣（myoclonus）、瞳孔擴大、心跳 130 次/min、血壓 185/100 mmHg、體溫 40°C，並出現肌肉僵硬、深腱反射亢進，動脈血分析 pH 7.52，$PCO_2$ 28 mmHg，$HCO_3$ 20 mEq/L。下列治療何者較適當？<br>（A）意識改變可能因合併 Benzodiazepine 的使用，可注射 Flumazenil 以逆轉該藥物的作用。<br>（B）給予 Dantrolene，降低高熱並改善肌肉僵直。<br>（C）立即注射 Lorazepam，可緩解神經興奮及肌陣攣。<br>（D）給予 Physostigmine，處理病人心跳快、血壓高與躁動的臨床表現。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| B | 166. | 68 歲男性因突發心悸、氣喘及頭暈就醫。高血壓病史，平時服用 Amlodipine。心電圖呈現心房顫動，生命徵象：GCS E4V5M6，心跳 140 次/min，血壓 100/60 mmHg，血氧飽和度 96%。控制心率，下列何者較適當？<br>（A）Amiodarone。<br>（B）Diltiazem。<br>（C）Flecainide。<br>（D）Digoxin。 |
| B | 167. | 28 歲男性昏迷送至急診，到院時 GCS E1V2M3，呼吸 6 次/min，血氧飽和度 78%，瞳孔縮小（miosis）。動脈血氣體分析：pH 7.21、$PaCO_2$ 70 mmHg、$PaO_2$ 55 mmHg、$HCO_3^-$ 24 mEq/L，血糖 95 mg/dL，腦部電腦斷層無異常。下列處置何者較適當？<br>（A）給予插管並使用機械通氣，以防止惡化為完全性呼吸衰竭。<br>（B）給予靜脈注射 Naloxone 2 mg，並視病人反應決定是否追加。<br>（C）給予非再吸入型氧氣面罩並監測 10 分鐘，若無改善則考慮使用 Naloxone。<br>（D）給予靜脈注射 Flumazenil 0.2 mg，以逆轉可能的苯二氮平（Benzodiazepine）中毒。 |
| D | 168. | 79 歲男性，2 小時內出現 4 次大量暗紅色血便，伴有頭暈與乏力。平常使用 Aspirin 與 Warfarin。生命徵象：血壓 98/65 mmHg，心跳 112 次/min，$SpO_2$ 97%。超音波無腹水，肛診為大量暗紅血便。Hb 8.2 g/dL，BUN 30 mg/dL，Cr 1.2 mg/dL。關於定位出血部位，下列何種影像檢查較適當？<br>（A）血管攝影。<br>（B）鋇劑對比攝影。<br>（C）核醫紅血球掃描（RBC scintigraphy）。<br>（D）電腦斷層血管攝影。 |
| C | 169. | 8 歲男童，由家長帶至急診，主訴喉嚨痛 2 天，無咳嗽及流鼻水症狀。檢傷生命徵象，體溫 38.5℃，心跳 110 次/min，血壓 100/70 mmHg，血氧 95%。身體診察發現雙側扁桃腺化膿、無潰瘍，頸部前方一顆淋巴結腫大。下列敘述何者較適當？<br>（A） 致病菌常為盤尼西林抗藥性（penicillin resistant）菌種。<br>（B） 抗原檢測陽性，仍應進行喉頭拭子細菌培養。<br>（C）可等候培養結果再使用抗生素治療。<br>（D）此致病菌鮮少引起懸壅垂（uvula）發炎。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 170. | 65 歲男性因急性上消化道出血接受多次輸血，今日輸血過後約 6 小時出現急性呼吸窘迫、低血氧 $SpO_2$ 85%，聽診雙側肺部有細濕囉音（crackles），且胸部 X 光顯示雙側肺部瀰漫性浸潤（bilateral infiltrates）。較可能的診斷為何？<br>（A）急性心衰竭（acute heart failure）。<br>（B）輸血相關循環負荷過重（transfusion-associated circulatory overload, TACO）。<br>（C）輸血相關急性肺損傷（transfusion-related acute lung injury, TRALI）。<br>（D）急性肺栓塞（acute pulmonary embolism）。 |
| B | 171. | 62 歲男性，心跳停止經急救仍不幸死亡。準備向其妻子與成年女兒宣告病人死亡，依照 GRIEV_ING 原則，應先進行下列哪一步驟？<br>（A）與家屬接觸，確認其與病人的關係，並開始說明急救過程，以提供有條理的敘述來過渡至死亡通知。<br>（B）先介紹自己，確認病人與家屬的身份與關係，評估家屬對當前狀況的理解，並適當鋪陳即將傳達的消息。<br>（C）在進行死亡通知前，先詢問家屬對於生死議題的宗教或文化信仰，以確保符合其價值觀與習俗。<br>（D）先靜默地與家屬共處幾分鐘，讓他們自由表達情緒，然後再開始討論病人的狀況。 |
| C | 172. | 6 歲女童於過去 48 小時內逐漸出現步態不穩與下肢無力，今日早晨雙手也開始變得無力。過程沒有發燒、頭痛、背痛或近期感染。家屬表示她一週前曾與家人到森林露營。神經學檢查發現：對稱性、上行性肌肉無力（ascending weakness）、深層肌腱反射（DTR）減弱、感覺功能正常、腦神經功能正常，無吞嚥困難、言語不清或視力模糊。下列處置何者較適當？<br>（A）緊急靜脈注射免疫球蛋白（IVIG）。<br>（B）立即進行腰椎穿刺。<br>（C）先仔細檢查病人的頭皮與全身皮膚。<br>（D）緊急進行腦部 MRI。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| B | 173. | 55 歲男性，有倦怠與多尿。血糖為 286 mg/dL，HbA1c 為 8.2%，無酮酸中毒或高滲透壓狀態。無糖尿病史，eGFR 為 65 mL/min/1.73 m²，生命徵象穩定，無感染或其他急性誘發因素，評估後無住院需求。下列何者為在急診中較適當的初始處置策略？<br>（A）暫不啟動藥物治療，先進行生活飲食調整，安排 24~48 小時內回診追蹤。<br>（B）開立 Metformin，安排 24~48 小時內回診追蹤。<br>（C）靜脈輸注胰島素將血糖控制至 200 mg/dL 內，安排 24~48 小時內回診追蹤。<br>（D）開立 SGLT2 抑制劑，安排 24~48 小時內回診追蹤。 |
| C | 174. | 32 歲孕婦，懷孕 34 週，在家中突然昏倒，家屬立即撥打 119，送至急診時無呼吸、無脈搏。醫療團隊開始心肺復甦術。下列急救處置何者較適當？<br>（A）進行 CPR 時，胸外按壓位置與一般成人相同。<br>（B）插管時應選擇較大號之氣管內管，以維持胎兒氧氣供應。<br>（C）進行 CPR 時，應將子宮推往左側。<br>（D）因孕期生理改變，電擊去顫（defibrillation）需將能量上調 1.5 倍，並盡速安裝胎兒監視器。 |
| A | 175. | 32 歲男性 4 週前右手腕受傷，X 光顯示無骨折，今日回診時舟狀骨壓痛，X 光顯示舟狀骨近端有骨質吸收跡象。下列何者為較可能的併發症？<br>（A）舟狀骨缺血性壞死（avascular necrosis）。<br>（B）舟月韌帶損傷（scapholunate ligament injury）。<br>（C）腕骨關節炎（wrist osteoarthritis）。<br>（D）舟狀骨假關節（scaphoid nonunion）。 |
| C | 176. | 60 歲男性，主訴持續喘。$SpO_2$ 84%，使用純氧面罩後 $SpO_2$ 上升至 86%，無代謝性酸中毒或乳酸中毒。下列哪一種機轉最能解釋該病人在給予氧氣後仍持續性的低氧血？<br>（A）通氣血流灌注配合不良（V/Q mismatch）。<br>（B）因敗血症導致心輸出量下降。<br>（C）肺實質右至左肺內分流（intrapulmonary right-to-left shunt）。<br>（D）擴散障礙。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| B | 177. | 40 歲男性因右側臉頰紅腫、疼痛且發燒至急診求診。身體診察發現右側下頜角處壓痛明顯，擠壓腮腺管（Stensen's duct）時可見膿性分泌物流出。最可能的診斷為何？<br>（A）病毒性腮腺炎（Viral parotitis）。<br>（B）化膿性腮腺炎（Suppurative parotitis）。<br>（C）頜下腺結石（Submandibular sialolithiasis）。<br>（D）牙源性感染擴散至咀嚼肌間隙（Masticator space infection）。 |
| D | 178. | 35 歲男性車禍後被送至急診，到院時意識昏迷（GCS 6）、心跳 135 次/min、血壓 78/46 mmHg，$SpO_2$ 93%，四肢冰冷，初步創傷超音波（eFAST）顯示腹腔與骨盆腔均有積液，無氣血胸。快速給予 1,000 mL 生理食鹽水後，血壓無明顯改善。下一步處置何者較不適當？<br>（A）立即啟動大量輸血流程（massive transfusion protocol）。<br>（B）儘早給予 Transamic acid 1g IV stat，之後每 8 小時 1 g。<br>（C）緊急會診創傷外科醫師安排進一步手術處置。<br>（D）安排電腦斷層以確認是否有腦出血及腹腔內出血。 |
| A | 179. | 2 歲男童，因發燒、雙耳疼痛就醫，4 天前曾在診所診斷中耳炎，服用 Amoxicillin 90 mg/kg/day。耳鏡（otoscopy）檢查發現左耳鼓膜腫脹、發紅，右耳鼓膜腫脹，不透明，疑似有穿孔。下列哪一項抗生素的選擇較不適當？<br>（A）加上口服 Ciprofloxacin 10 mg/kg/day，再治療 3 天。<br>（B）收住院靜脈注射 Ceftriaxone 50 mg/kg/day，再治療 3 天。<br>（C）改用口服 Amoxicillin-clavulanate 90 mg/kg/day，再繼續治療 10 天。<br>（D）改用口服 Clindamycin 36 mg/kg/day，再治療 10 天。 |
| C | 180. | 42 歲男性，患有僵直性脊椎炎，今於浴室滑倒後背痛加劇，雖能行走但持續主訴疼痛。身體診察發現脊椎局部壓痛，四肢神經檢查正常。X 光未見骨折，給予止痛藥後，準備安排動向。下列處置何者較適當？<br>（A）建議臥床休息並安排 1 週內骨科門診追蹤。<br>（B）依目前檢查結果安排返家觀察並使用止痛藥。<br>（C）安排頸胸椎 CT 或 MRI 評估潛在脊椎骨折或不穩定病變。<br>（D）建議轉介復健科評估以調整慢性背痛藥物及運動處方。 |

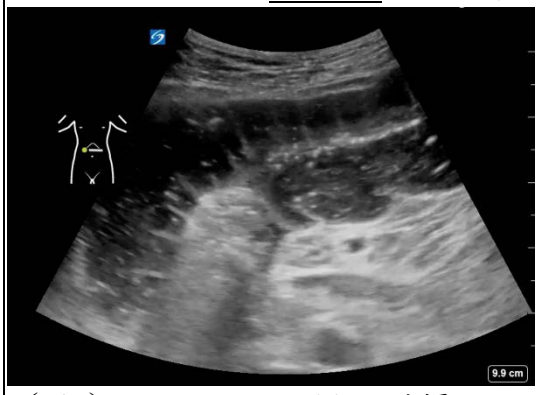
# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 181. | 2 週大的新生兒因膽汁性嘔吐（bilious vomiting）、嗜睡及腹脹來急診。無發燒或腹瀉症狀。腹部 X 光顯示腸道遠端氣體減少，可能為腸道阻塞。下一步處置何者較適當？<br>（A）進行腹部電腦斷層掃描（abdominal computed tomography）。<br>（B）安排空氣對比鋇劑灌腸攝影（air-contrast enema）。<br>（C）進行上消化道鋇劑攝影（upper GI series with contrast）。<br>（D）給予廣效抗生素並於 6 小時後重新評估。 |
| A | 182. | 50 歲女性右膝髕骨橫斷性閉鎖性骨折，移位約 4 mm。下列處置何者較適當？<br>（A）安排開放性復位及內固定手術（ORIF）。<br>（B）使用功能性護具固定並盡早開始活動。<br>（C）石膏固定 6 週，限制膝關節活動及承重。<br>（D）給予止痛藥物，安排後續骨科門診追蹤。 |
| D | 183. | 65 歲女性，主訴 6 小時前開始頭暈噁心上腹悶痛，有冒冷汗的情況。血壓 140/90 mmHg，心跳 80 次/min、血氧 95%。下列臨床判斷的敘述何者較適當？<br>（A）若病人心電圖無明顯 ST 段上升或 T 波倒置，可排除急性冠心症的可能。<br>（B）若病人本身有糖尿病，可作為此次表現為急性冠心症的預測因子（prediction factor）。<br>（C）胸痛時執行心電圖若呈現 V2-3 T 波倒置，可能是 Wellen's syndrome。<br>（D）急性冠心症以非典型症狀表現者，相較於典型胸痛表現者，前者的預後較差。 |
| C | 184. | 70 歲糖尿病男性，因右髖部劇烈疼痛和腫脹，病人有右側慢性足部潰瘍。身體檢查發現右側髖部局部溫熱和發紅，若懷疑骨髓炎，下列經驗性抗生素組合何者是最佳選擇？<br>（A）Clindamycin plus Ciprofloxacin。<br>（B）Vancomycin。<br>（C）Vancomycin plus Piperacillin-Tazobactam。<br>（D）Vancomycin plus Ceftazidime。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| B | 185. | 68 歲男性，過去病史包括冠狀動脈疾病與充血性心衰竭，因突發胸悶與暈厥就醫。過去 24 小時內被植入式心律整流除顫器（implantable cardioverter-defibrillator, ICD）施行電擊 3 次。檢查後懷疑是裝置誤判導致放電。下列處置何者較適當？<br>（A）ICD 執行電擊後，病人的心電圖會呈現持續性 ST 段上升。<br>（B）若懷疑 ICD 因爲錯誤偵測而頻繁錯誤放電，可在裝置上放置磁鐵，以暫停 ICD 放電功能，待心臟科進一步評估。<br>（C）安裝 ICD 的病人最常見的死因是致命性心律不整。<br>（D）若 ICD 曾暴露於強力磁性物質（如：磁鐵），磁性物質被移除後若 ICD 仍能執行放電功能，就不需要照會心臟科評估。 |
| C | 186. | 病人左側尺骨近端骨折，無法進行前臂旋轉（pronation/supination），可能合併未被辨識的問題。下列何者較適當？<br>（A）施以長臂後側夾板固定後，並安排隔天骨科門診追蹤。<br>（B）安排進一步 X 光或 CT，確認橈骨頭及是否合併脫臼。<br>（C）評估橈骨頭（radial head）與肱骨小頭（capitellum）的對位是否正常。<br>（D）合併橈骨頭脫臼，必須會診骨科手術。 |
| A | 187. | 50 歲女性，發生急性共濟失調和眼球運動異常，病人有長期酗酒。就醫時意識混亂。下列哪項是較適當的初始治療？<br>（A）靜脈注射 Thiamine。<br>（B）靜脈注射 Naloxone。<br>（C）靜脈注射高劑量 Steroids。<br>（D）靜脈注射 Flumazenil。 |
| C | 188. | 68 歲女性，慢性頸部疼痛病史多年，時好時壞，但最近 2 個月持續加重，無外傷史。身體診察顯示右上肢肌力減弱為 4 分，輕度感覺異常。下一步處置何者較適當？<br>（A）因頸部疼痛已超過 6 週，可直接安排門診追蹤檢查。<br>（B）將病人右手放置於頭上能夠減緩其右上肢疼痛，為 abduction relief sign，暗示可能為韌帶或肌肉病灶。<br>（C）Three-view cervical spine films 與先前比較無明顯異常，仍須安排核磁共振檢查。<br>（D）此病人是慢性頸部疼痛，應優先使用止痛藥物治療。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| D | 189. | 下列何者為心臟鈍傷心電圖最常見的表現？<br>（A）短暫性 ST 段抬高，類似急性心肌梗塞（STEMI）。<br>（B）右束支傳導阻滯（RBBB）。<br>（C）心室性早期收縮（PVCs）。<br>（D）竇性心搏過速（Sinus Tachycardia）。 |
| B | 190. | 38 歲男性，無過往病史，於高強度重訓後突發劇烈雷擊性（thunderclap）頭痛，疼痛於數秒內達到巔峰，並伴隨噁心、短暫右側肢體無力及感覺異常。就醫時症狀已改善，神經學檢查無異常，眼底檢查無乳突水腫，腦部電腦斷層（無顯影劑）正常。下列處置何者較適當？<br>（A）進行腰椎穿刺以排除蛛網膜下腔出血。<br>（B）進行 MRA 以評估頸動脈與椎動脈剝離。<br>（C）進行頸動脈與椎動脈超音波以初步篩檢可逆性腦血管收縮症候群。<br>（D）病人無持續症狀，以止痛治療後門診追蹤，並建議避免劇烈運動。 |
| C | 191. | 65 歲女性，腹痛、嘔吐與無排氣 2 天。身體診察發現腹部膨脹、有高頻腸音、觸診有輕微中上腹壓痛，無反彈痛，超音波影像如下。生命徵象穩定。下列何者為較適當的下一步處置？<br>  <br>（A）進行口服鋇劑腸道攝影。<br>（B）立即進行手術會診與剖腹探查。<br>（C）置放鼻胃管並進行腹部電腦斷層。<br>（D）進行灌腸。 |
| C | 192. | 33 歲女性產後第 2 週正在哺乳，主訴左側乳房疼痛、腫脹與發燒。使用 dicloxacillin 治療，但未改善。超音波顯示 4 公分具分隔的低回音液體集區（loculated hypoechoic fluid collection）。下列處置何者較適當？<br>（A）使用磺胺類（如 SMX-TMP）抗生素。<br>（B）初步考慮切開引流，避免病情加重。<br>（C）靜脈注射抗生素並安排住院為合理的選擇。<br>（D）寶寶可能吸入乳房膿瘍，應該停止哺乳。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| D | 193. | 72 歲男性因心跳停止接受 CPR，恢復自主循環後，目前仍處於昏迷狀態，已置放氣管內管並使用呼吸器。動脈血氣體分析（ABG）顯示：pH 7.47、$PaO_2$ 210 mmHg、$PaCO_2$ 35 mmHg。下一步較佳的處置是？<br>（A）降低呼吸速率，以增加 $PaCO_2$以補償鹼中毒。<br>（B）提高潮氣容積（tidal volume），增加通氣量。<br>（C）持續維持高氧輸送，確保腦組織氧合最大化。<br>（D）調整 $FiO_2$，目標 $SaO_2$ 94~98%。 |
| D | 194. | 25 歲男性派對後出現感官扭曲（sensory distortion）、瞳孔放大、高血壓與極度焦躁。下列敘述何者較適當？<br>（A）尿液毒物篩檢是診斷幻覺劑（Hallucinogens）中毒的主要工具。<br>（B）幻覺劑（Hallucinogens）中毒的精神症狀能與原發性精神病容易區分。<br>（C）胃灌洗與活性碳應作為第一線處置選擇。<br>（D）出現嚴重焦躁、高體溫或抽搐時，應考慮插管。 |
| C | 195. | 外傷性腦傷為了預防 secondary brain injury，下列處置何者較適當？<br>（A）靜脈注射甘露醇（Mannitol）1 g/kg。<br>（B）靜脈注射 Tranexamic acid 1,000 mg。<br>（C）積極輸液以維持 MAP ≥ 80 mmHg。<br>（D）使用呼吸器控制 $PaCO_2$ < 30 mmHg。 |
| C | 196. | 72 歲女性，患有第二型糖尿病已 15 年，合併輕度慢性腎病與心臟衰竭，目前服用 Metformin 1000 mg BID、HbA1c 為 8.2%、BMI 32。醫師考慮加入第二線口服降血糖藥物，避免體重上升與低血糖。下列藥物選擇何種較適當？<br>（A）Glyburide。<br>（B）Pioglitazone。<br>（C）Linagliptin。<br>（D）Repaglinide。 |

# 114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試試題及答案(A)

| 答案 | 題號 | 題目 |
|---|---|---|
| C | 197. | 45 歲女性，有反覆出現水泡及糜爛性皮膚病灶，身體檢查發現皮膚有大而鬆弛的水泡，破裂後形成糜爛的潰瘍，並有明顯疼痛。輕壓未破損的皮膚即出現表皮剝離，病理切片發現棘層鬆解（acantholysis）。較可能的診斷為何？<br>（A）類天皰瘡（bullous pemphigoid）。<br>（B）多形性紅斑（erythema multiforme）。<br>（C）尋常性天皰瘡（pemphigus vulgaris）。<br>（D）壞死性毒性表皮溶解症（toxic epidermal necrolysis）。 |
| C | 198. | 5 歲正常發育兒童，因急性呼吸衰竭病症，已進行氣管內管插管並使用呼吸器，準備利用直升機轉送，由離島緊急轉送台灣本島。有關直升機轉送的特殊風險，下列敘述何者較適當？<br>（A）高空環境的高溫傷害。<br>（B）低壓環境導致肺部擴張不足。<br>（C）氣管內管氣囊（cuff）壓力上升。<br>（D）誘發肺栓塞風險提高。 |
| D | 199. | 58 歲女性，有真性紅血球增生症（polycythemia vera），長期接受治療。腹脹疼痛 3 天，身體診察有明顯腹水、肝臟明顯腫大且右上腹壓痛，無腹膜炎。超音波檢查發現肝靜脈有血栓形成，門靜脈正常，無肝硬化徵象。檢驗：INR 1.4，血小板 250,000 /μL。下列何者處置較適當？<br>（A）立即給予血栓溶解劑治療。<br>（B）啟動導管溶栓治療。<br>（C）穿刺放腹水並觀察。<br>（D）應給予抗凝血劑治療，並轉介肝臟專科評估介入治療。 |
| A | 200. | 骨盆腔發炎性疾病（PID）經急診處置後可於門診治療，下列藥物何者較適當？<br>（A）Ceftriaxone 250 mg 單次肌肉注射與 Doxycycline 100 mg 一天兩次口服 14 天。<br>（B）Cefoxitin 2 g 單次肌肉注射與 Metronidazole 500 mg 一天兩次口服 14 天。<br>（C）Ceftriaxone 250 mg 單次肌肉注射與 Metronidazole 500 mg 一天兩次口服 14 天。<br>（D）Ofloxacin 400 mg 一天兩次與 Doxycycline 100 mg 一天一次口服 14 天。 |